6 Gesundheitsverhaltensmodelle

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- kennen Sie wichtige Theorien und Modelle zur Vorhersage und Erklärung von Gesundheitsverhalten
- können Sie die Komponenten und Wirkpfade der verschiedenen Theorien und Modelle erklären,
- kennen Sie die Ergebnisse von Meta-Studien, die Effekte der verschiedenen Theorien und Modelle in Bezug auf Gesundheitsverhalten bestimmt haben,
- können Sie die Güte der Theorien und Modelle beziehungsweise ihrer Komponenten beurteilen.

Unter Gesundheitsverhalten werden alle Verhaltensweisen gezählt, die die Gesundheit fördern und langfristig erhalten. Grob kann Gesundheitsverhalten in die Ausführung von gesundheitsförderlichem Verhalten (gesunde Ernährung, sportliche Aktivität) und die Unterlassung von gesundheitsgefährdendem Verhalten (Alkoholkonsum, Rauchen) unterteilt werden. Die Ausführung von Gesundheitsverhalten hat positive Auswirkungen auf die einzelne Person. Trotzdem führen viele Menschen weder gesundheitsförderliches Verhalten aus, noch unterlassen sie gesundheitsgefährdendes Verhalten (siehe Kurs 1, Kapitel 2 „Gesundheitsbezogenes Verhalten").

Grundlegende Informationen darüber, welche Prozesse dem Ausüben oder Unterlassen von Verhalten auch im Bereich Gesundheit und Krankheit zugrunde liegen, haben Sie bereits in Kurs 1, Kapitel 5 „Regulation gesundheitsbezogenen Verhaltens" kennengelernt, in dem Theorien zu Selbstregulationsprozessen und den hiermit eng verknüpften Zielen ausgeführt wurden. Selbstregulationsprozesse sind dabei für die Zielerreichung notwendig und werden je nach Theorie durch Handlungsergebniserwartungen, wahrgenommene Barrieren (z. B. konkurrierende Ziele) oder die Selbstwirksamkeitserwartung beeinflusst. In diesem Punkt sind Theorien zu Selbstregulationsprozessen den Gesundheitsverhaltensmodellen sehr ähnlich, da beide Ansätze den Anspruch erheben, anhand verschiedener, sich teilweise überschneidender Faktoren gesundheitsbezogenes (Ziel-)Verhalten vorherzusagen. Während jedoch Selbstregulationstheorien eher darauf ausgelegt sind, intrapersonal stattfindende, sowohl bewusste als auch nicht-bewusste Vorgänge zur möglichen Zielerreichung zu beschreiben, dient die lange Forschungstradition der Gesundheitsverhaltensmodelle dem Zweck, entscheidende Stellschrauben zu identifizieren, über deren Veränderung eine Veränderung im Gesundheitsverhalten hervorgerufen werden kann. Gesundheitsverhaltensmodelle setzen eher an bewusst stattfindenden und willentlich steuerbaren Faktoren an und wollen Ansätze aufzeigen, die dabei helfen, diese Faktoren auch von außen zu verändern, wie zum Beispiel durch modellbasierte Interventionen. Gesundheitsverhaltensmodelle können daher sowohl für die Prävention als auch für die Gesundheitsförderung genutzt werden, da durch den Aufbau gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen und den Abbau von gesundheitsschädigendem Verhalten beispielsweise kardiovaskulären Erkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, Krebs und weiteren in der westlichen Welt zunehmenden gesundheitlichen Problemen entgegengewirkt werden kann.

Unterteilung von Gesundheitsverhaltensmodellen

Allgemein können Modelle des Gesundheitsverhaltens in kontinuierliche Prädiktionsmodelle und dynamische Stadien- oder Stufenmodelle aufgeteilt werden (Sniehotta et al., 2003).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Kontinuierliche Prädiktionsmodelle gehen davon aus, dass es einen linearen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Modellkomponenten und der Wahrscheinlichkeit, Gesundheitsverhalten auszuüben, gibt. Dies bedeutet, je stärker beziehungsweise niedriger die Ausprägung auf den verschiedenen Komponenten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Gesundheitsverhalten beziehungsweise die Intention Gesundheitsverhalten auszuführen, wobei der Einfluss der verschiedenen Komponenten unterschiedlich gewichtet sein kann. Die kontinuierlichen Theorien und Modelle des Gesundheitsverhaltens versuchen also zu klären, warum ein Gesundheitsverhalten ausgeübt oder nicht ausgeübt wird und welche Faktoren dies am besten Vorhersagen können. Diese Faktoren werden in dem Zusammenhang auch Prädiktoren genannt und umfassen zumeist kognitive Komponenten (z. B. Bedrohungseinschätzung). In jüngerer Forschung rückt zudem auch die Bedeutsamkeit affektiver Komponenten (z. B. negativer Affekt) in den Vordergrund, die bisher noch sehr wenig in Gesundheitsverhaltensmodellen berücksichtigt wurden (z. B. Reuter & Renner, 2011).

Den kontinuierlichen Prädiktionsmodellen stehen die *dynamischen Stadien- oder Stufenmodelle* gegenüber. Dynamische Stufenmodelle haben ebenso das Ziel, Gesundheitsverhalten vorherzusagen und zu erklären, gehen aber nicht davon aus, dass eine Verhaltensänderung auf einem fortschreitenden Kontinuum passiert, sondern, dass ein Individuum während der Verhaltensänderung verschiedene Stadien oder Stufen durchläuft. Die Modelle werden als dynamisch bezeichnet, da sich Personen auf verschiedenen Stufen hin und her bewegen können. Dabei schließen sich die Stadien beziehungsweise Stufen gegenseitig aus, das heißt ein Individuum kann sich nur auf einer einzigen Stufe beziehungsweise in einem einzigen Stadium befinden und nicht auf mehreren zugleich. Im Gegensatz zu kontinuierlichen Prädiktionsmodellen stehen bei Stufenmodellen die unterschiedlichen Phasen oder Stufen der Gesundheitsveränderung im Fokus. Da jede Stufe andere Ziele besitzt und unterschiedliche Herausforderungen birgt, müssen pro Stufe andere Maßnahmen getroffen beziehungsweise Interventionen entwickelt werden, um Veränderungen hervorzurufen. Daher spricht man bei Interventionen, die auf Stufenmodellen beruhen, von maßgeschneiderten Interventionen (engl.: tailored interventions). Demgegenüber sind Interventionen, die auf kontinuierlichen Prädiktionsmodellen beruhen, für alle Personen stets identisch.

Armitage und Conner (2000) fügen den kontinuierlichen Prädiktionsmodellen und den Stufenmodellen noch den *behavioral enaction Typ* oder auch *volitionalen Modelltyp* hinzu. Hierunter fallen Konzepte und Theorien, die sich mit dem Prozess der Umsetzung von Intentionen in Verhalten beschäftigen beziehungsweise die die Beziehung zwischen Intentionen und Verhalten erklären (z. B. die Forschung um die Intentions-Verhaltens-Lücke). In diesem Sinne werden die kontinuierlichen Prädiktionsmodelle auch als motivationale Modelltypen bezeichnet, da sie sich eher mit der Vorhersage der Intention beschäftigen, während volitionale Ansätze sich mit Faktoren auseinandersetzen, die die Umsetzung der Intention in Verhalten begünstigen.

Die Bereiche, die Gesundheitsverhaltensmodelle abzudecken versuchen, erstrecken sich über eine weite Spanne, wie zum Beispiel die Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen, Kondomnutzung, um sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen, Sonnenschutzverhalten, Impfungen, Rauchentwöhnung, gesunde Ernährungsweise, körperliche Betätigung etc. Dabei gibt es in der Forschung große Unterschiede an bisher durchgeführten Untersuchungen zu den verschiedenen Bereichen und an Untersuchungen in verschiedenen Kulturen. Zudem ist es wahrscheinlich, dass sich die verschiedenen Prädiktoren in ihrer Vorhersagekraft mit Blick auf das vorherzusagende Verhalten unterscheiden. Im Folgenden werden die unterschiedlichen, prominentesten Modelle im Bereich der Gesundheitspsychologie vorgestellt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

6.1 Modell gesundheitlicher Überzeugungen (Health Belief Model, HBM)

Das HBM gehört einerseits zu den kontinuierlichen Prädiktionsmodellen, ist aber auch den Furchtappell-Theorien zuzuordnen. Furchtappell-Theorien gehen davon aus, dass Personen mit Risiken konfrontiert werden müssen, um ihr Verhalten zu ändern. Furchtappelle sind persuasive Botschaften, die einem Empfänger mitteilen, dass für ihn relevante Werte bedroht sind (siehe Abbildung 6.1 und Video 6.1 sowie Kurs 2, Kapitel 2 „Gesundheitskommunikation").

Das HBM gehört zu den einflussreichsten und ältesten Modellen der Gesundheitspsychologie. Es wurde Mitte des 20. Jahrhunderts von Rosenstock (1966) erstellt und später von Becker (1974) weiterentwickelt und sollte der Vorhersage von Gesundheitsverhalten, wie z. B. Impfungen oder Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen, dienen. Eine Grundannahme des Modells ist es, dass sich Menschen rational verhalten, wenn sie sich durch eine Krankheit bedroht fühlen und negative Folgen diesbezüglich erwarten. Um eine tatsächliche Vorhersage für das Gesundheitsverhalten treffen zu können, muss laut dem Modell zudem eine weitere Komponente berücksichtigt werden: die erwartete Effektivität des auszuführenden Verhaltens.

Abbildung 6.1

Plakate von verschiedenen Gesundheitskampagnen basiert auf dem Konzept des Furchtappells. Verfügbar unter https://www.adforum.com/creative-work/ad/player/6703642/killer-sofa/hsc-foundation (Killer Sofa); http://www.tobaccolabels.ca/countries/australia/ (Smoking harms unborn babies); https://www.hannelore-kohl-stiftung.de/shop/produktdetails/?tt_products%5BbackPID%5D=374&tt_products%5Bproduct%5D=20&cHash=efd15bd99d6b24019032914860741b15 (Ein Helm hilft); https://www.runtervomgas.de/aktuelles-und-downloads/aktuelles/autobahnplakate-2018/ (Runter vom Gas); http://www.tobaccolabels.ca/countries/australia/ (Smoking causes mouth and throat cancer)



Video 6.1. Die letzte Nachricht – Kopf hoch – Hände weg vom Handy (N-JOY, NDR)! Verfügbar unter https://youtu.be/7mXw1WBoT3c

6.1.1 Modellkomponenten des HBM

Sowohl das Bedrohungsempfinden als auch die erwartete Effektivität setzen sich aus jeweils zwei Komponenten zusammen.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

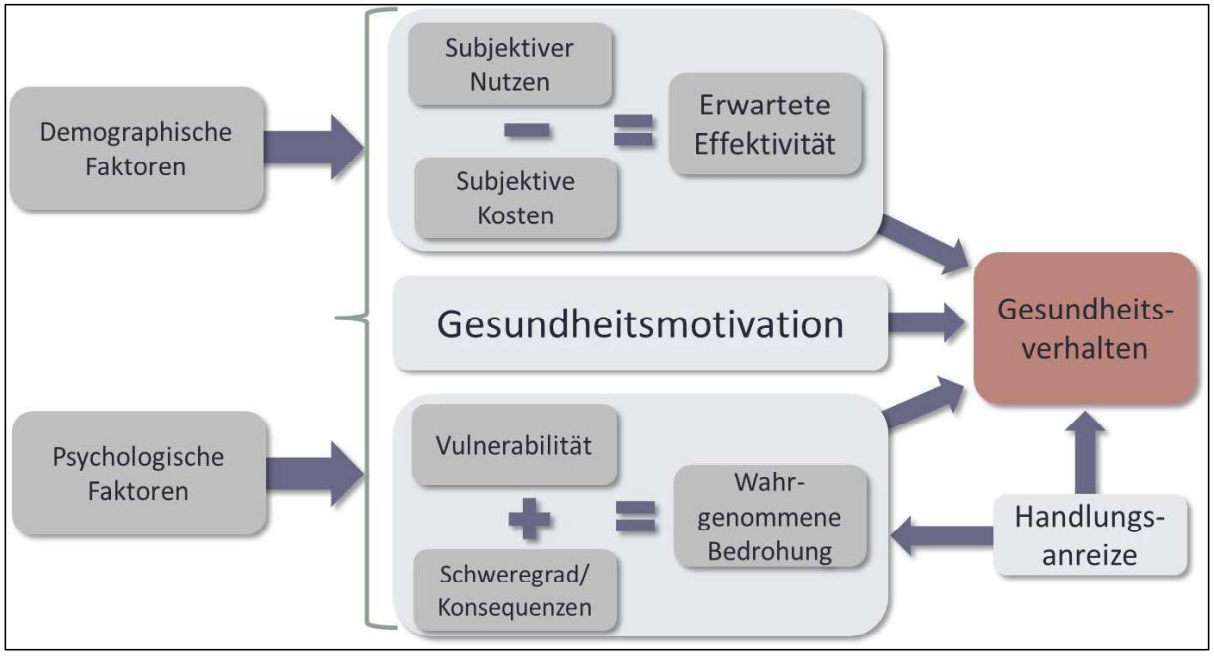
Das *Bedrohungsempfinden* entsteht zum einen aus der subjektiv eingeschätzten Anfälligkeit (Vulnerabilität) für eine Erkrankung und zum anderen aus der Einschätzung des Schweregrads beziehungsweise der Konsequenzen der Erkrankung. Dabei kann zum Beispiel die subjektive Anfälligkeit für eine Krebserkrankung als höher eingeschätzt werden, wenn in der biologischen Familie hierfür eine erhöhte Prävalenz zu finden ist. Die Einschätzung des Schweregrads basiert auf den Informationen, die eine Person über eine Krankheit und ihre Konsequenzen hat. Im Allgemeinen gilt zum Beispiel Lungenkrebs als eine schwere Erkrankung mit häufiger Todesfolge, während ein leichter Husten als unangenehm, aber ohne langfristige Auswirkungen eingeschätzt wird.

Auch die zweite Komponente des HBM, die *erwartete Effektivität*, wird in zwei Teile untergliedert, welche die Kosten und den Nutzen des potenziellen Gesundheitsverhaltens umfassen. Kosten und Nutzen werden dabei stets miteinander verrechnet, um festzustellen, welche Komponente überwiegt. Im Falle der Prävention einer Krebserkrankung könnte beispielsweise die Umstellung auf gesunde Ernährung als wirksam eingeschätzt werden. Jedoch stellt für viele Personen der permanente Verzicht schmackhafter Nahrung einen großen Kostenfaktor dar. Hier müsste nun der subjektive Nutzen oder auch die wahrgenommene Bedrohung sehr hoch sein, damit das Verhalten trotzdem noch ausgeführt wird. Eine bessere Bilanz könnte in diesem Beispiel das Wahrnehmen von Vorsorgeterminen erzielen, bei dem die Kosten zeitliche (und teilweise finanzielle) sind, die jedoch nicht täglich, sondern nur einmal im Jahr anfallen.

Ein Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten findet sich in Abbildung 6.2.

Abbildung 6.2

Modell gesundheitlicher Überzeugungen



Im Laufe der Jahre haben einige Autor:innen, wie zum Beispiel Becker (1974), das Modell fortwährend weiterentwickelt. So wurde noch die Komponente der Gesundheitsmotivation hinzugefügt, also die generelle Bereitschaft, sich mit gesundheitsbezogenen Thematiken auseinanderzusetzen. Die Gesundheitsmotivation wird dabei maßgeblich von distalen Variablen, wie soziodemographischen Faktoren (Alter, Geschlecht), sozialen Faktoren (Gruppendynamik), psychologischen Faktoren (Persönlichkeit) und dem Wissen über bestimmte Risiken, beeinflusst.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Des Weiteren wurden Hinweisreize oder Handlungsanreize dem Modell hinzuaddiert. Diese können einmal äußere Reize, wie beispielsweise Gesundheitskampagnen, oder auch innere Reize, wie die Wahrnehmung von Symptomen, umfassen. Das Vorliegen bestimmter Hinweisreize erhöht dabei die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Gesundheitsverhalten zu zeigen, auch können Bedrohungen aufgezeigt und damit erhöht werden.

Furchtappelle im HBM

Eine essenzielle Komponente des HBM ist das subjektive Empfinden von Bedrohung. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die tatsächliche Bedrohung durch eine Krankheit, sondern um die subjektive Einschätzung dieser Bedrohung (engl.: health beliefs), also das Bedrohungsempfinden. Diese Unterscheidung ist bedeutsam, da viele Menschen einer Fehleinschätzung unterliegen, wenn es um die Gefährdung der eigenen Person durch eine Krankheit geht, da das eigene Krankheitsrisiko häufig unterschätzt wird (Weinstein, 1982). Das HBM geht davon aus, dass für die Herbeiführung von Gesundheitsverhalten die Wahrnehmung einer Bedrohung notwendig ist. Dies ist ein häufiger Bestandteil von Gesundheitskampagnen, wie zum Beispiel den Abschreck-Bildern auf Zigarettenschachteln oder Plakate, die stark alkoholisierte Jugendliche oder demolierte Unfallfahrzeuge zeigen (siehe Abbildung 6.1). Diese Maßnahmen können laut HBM das Bedrohungsempfinden erhöhen und gleichzeitig den eingeschätzten Nutzen für die Ausübung eines Verhaltens vergrößern. Damit lieferte das Modell als eines der ersten überhaupt Anhaltspunkte, um erste Maßnahmen für gesundheitsveränderndes Verhalten in der Praxis herbeizuführen. Kritisch anzumerken ist hierbei, dass das Modell keine Informationen darüber enthält, welche Prozesse bei den folgenden Schritten der Planung, Umstellung und Aufrechterhaltung Relevanz besitzen, da es volitionale Prozesse nicht berücksichtigt. Weiterhin wurde kritisiert, dass Furchtappelle starke negative Gefühle hervorrufen können, welche wiederum Risikofaktoren für gesundheitsschädigendes Verhalten (z. B. Konsum von Nikotin, Alkohol und schmackhafter Nahrung) darstellen, da dies oftmals zu einer kurzfristigen Verbesserung des Gemütszustands führt.

6.1.2 Befunde zum HBM

Die Vorhersagekraft der verschiedenen Komponenten für die Ausübung von Gesundheitsverhalten wurde erstmals anhand einer Meta-Analyse von Harrison et al. (1992) überprüft. Die Autor:innen fanden heraus, dass der prädiktive Wert der Faktoren Schweregrad, Vulnerabilität, Kosten und Nutzen zwar hypothesenkonform, jedoch insgesamt nur von geringem Wert war. Dabei zeigten die wahrgenommenen Kosten die stärksten und der subjektive Schweregrad/die wahrgenommenen Konsequenzen die schwächsten Assoziationen. Auch in einer Meta-Analyse von Carpenter (2010) wurden 18 Studien, die die vier Komponenten des HBM auf ihre prädiktive Aussagefähigkeit im Längsschnitt untersuchten, analysiert. Die mittleren Korrelationen zwischen den Komponenten des HBM und dem in den Studien der Meta-Analysen erfassten Gesundheitsverhalten (dieses erstreckt von Vorsorgeuntersuchungen über Zahnpflege, Kondomnutzung, Tabakabstinenz, Diät hin zu physischer Aktivität mit einer Spanne zur Vorhersage des Verhaltens zwischen 2 und 365 Tagen) zeigt Tabelle 6.1.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Tabelle 6.1

Mittlere Korrelationen zwischen den Komponenten des HBM und Gesundheitsverhalten

	Vulnerabilität	Schweregrad	Subjektiver Nutzen	Subjektive Kosten
Harrison et al. (1992)	.15	.08	.13	-.21
Carpenter (2010)	.05	.15	.27	-.30

Anmerkung. Die Korrelationskoeffizienten in dieser Tabelle geben die Richtung des inhaltlichen Zusammenhangs an, sind aber in den Original-Publikationen teilweise invertiert berechnet.

6.1.3 Das HBM aktuell

In der Analyse von Carpenter finden sich stärkere Zusammenhänge als in der von Harrison et al. (1992), wobei Carpenter betont, dass die Koeffizienten über die verschiedenen Verhaltensweisen stark variieren. Dennoch sind die gefundenen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Komponenten und dem Zielverhalten insgesamt als unzulänglich zu bewerten. Weiterhin scheint die Differenzierung zwischen volitionalen und motivationalen Prozessen unzureichend (Schwarzer, 2004) und daher ist das Modell eher als statisch, denn dynamisch zu beurteilen, was letztendlich dem prozesshaften Charakter einer Verhaltensänderung nicht gerecht wird. Auch das Fehlen der Einschätzung der eigenen Kompetenz beziehungsweise der Selbstwirksamkeitserwartung sowie der mangelnde Einbezug verschiedener sozialer und affektiver Faktoren werden mittlerweile als kritisch bewertet. Daher ist das HBM als erstes Gesundheitsverhaltensmodell zwar historisch bedeutsam, muss heutzutage jedoch als unzureichend und kaum noch haltbar bewerten werden.

6.2 Schutzmotivationstheorie (Protection Motivation Theory, PMT)

Die PMT nach Rogers (1975) ähnelt in ihren Komponenten dem HBM, integriert jedoch zusätzlich die Faktoren der *Selbstwirksamkeitserwartung* und *Schutzmotivation*. Letztere wird je nach zugrundeliegender Literatur auch mit der Intention anderer Gesundheitsverhaltensmodelle verglichen (Brinkmann, 2021). Die PMT gehört ebenso den Furchtappelltheorien und den kontinuierlichen Prädiktionsmodellen an und versucht, das Zusammenspiel der verschiedenen Variablen zu spezifizieren. Die PMT nimmt an, dass bei der Wahrnehmung von Informationen, die Gesundheit betreffen, zwei Bewertungsprozesse initiiert werden, die dann gemeinsam zur Bildung einer Schutzmotivation führen. Die Informationen für diese Bewertungsprozesse können aus unterschiedlichen Quellen stammen, wobei es sich sowohl um externe (z. B. Zeitungsartikel über die schädigenden Folgen fettreicher Nahrung) als auch um interne Quellen (z. B. Sodbrennen nach fettreichem Essen) handeln kann, oder durch Beobachtung erlangt werden. Somit stellt die Schutzmotivation eine Intention dar, ein bestimmtes Gesundheitsverhalten zu zeigen.

6.2.1 Modellkomponenten der PMT

Die Prozesse, die zur Bildung einer Schutzmotivation angestoßen werden, beziehen sich auf die Einschätzung der Bedrohung (ähnlich wie im HBM) sowie auf die Einschätzung der Bewältigungsmöglichkeiten.

Die *Bedrohungseinschätzung* ist hierbei als Kosten-Nutzen-Modell zu verstehen. Die Kosten setzen sich aus dem eingeschätzten Schweregrad der Bedrohung (z. B. „Rauchen verursacht Krebs“) in Kombination mit der eingeschätzten Vulnerabilität (z. B. „In meiner Familie besteht ein erhöhtes Krebsrisiko“) zusammen. Der Nutzen bezieht sich auf externe und interne Belohnungen durch das Risikoverhalten. Ein Beispiel für externe Belohnungsfaktoren wäre „Akzeptanz in einer

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

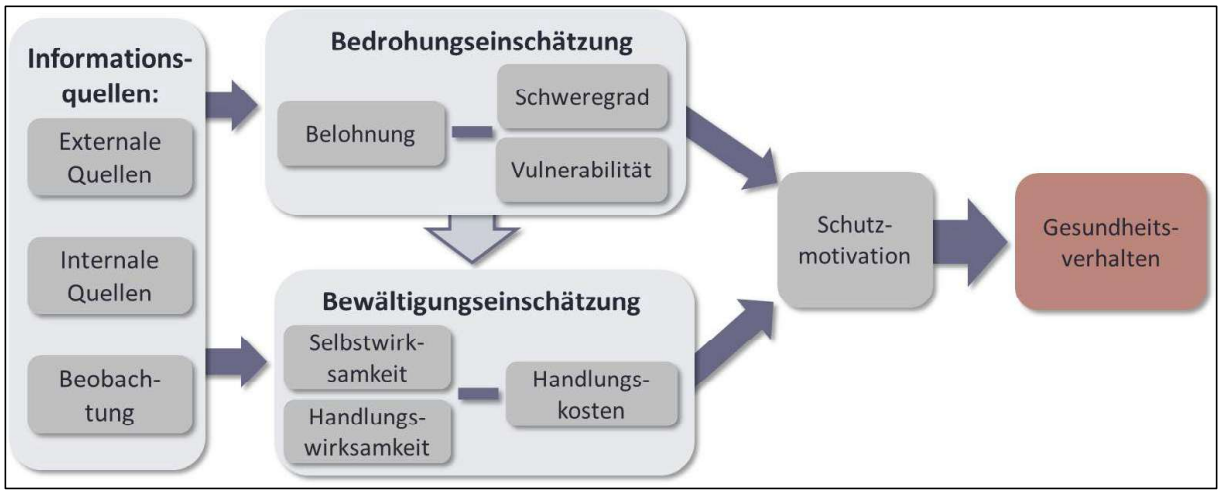
Gruppe durch Zigaretten rauchen“ und für interne Belohnungsfaktoren „Nervositätsreduktion durch Zigaretten rauchen“.

Auch die *Bewältigungseinschätzung* wird über das Kosten-Nutzen-Prinzip errechnet. Auf der einen Seite stehen die Handlungswirksamkeit und die Selbstwirksamkeitserwartung. Handlungswirksamkeit beinhaltet die Einschätzung der Effektivität des Verhaltens (z. B. „Aufhören mit Rauchen schützt vor Krebs“). Selbstwirksamkeitserwartung ist die Überzeugung, ein Verhalten auch bei aufkommenden Barrieren und Widerständen erfolgreich ausführen zu können (z. B. „Auch wenn meine Freunde weiterrauchen, kann ich aufhören“). Dem gegenüber stehen die Kosten, die die Ausführung eines bestimmten Verhaltens erfordert. Die Kosten können dabei vielfältig sein und emotionale Kosten (z. B. Aushalten von Entzugssymptomen), finanzielle Kosten (z. B. Nikotinersatzpräparate) oder auch soziale Kosten (z. B. Ausschluss aus einer Gruppe bei Alkoholabstinenz) umfassen.

Das Zusammenspiel der verschiedenen Prädiktoren in der PMT zur Vorhersage das Gesundheitsverhalten findet sich in Abbildung 6.3.

Abbildung 6.3

Die Schutzmotivationstheorie



Ähnlich wie im HBM können Maßnahmen, die eine Risikokommunikation beinhalten, der PMT zugeordnet werden. Durch die Berücksichtigung der Selbstwirksamkeitserwartung zeigen Kampagnen, die auf der PMT fußen, noch eine Empfehlung auf, wie und womit das Verhalten umgesetzt werden kann (mittlerweile stehen z. B. Hotlines zur Rauchentwöhnung auf Zigarettenpackungen).

6.2.2 Befunde zur PMT

Insgesamt gestaltet es sich aufgrund der Komplexität des Modells als schwierig, experimentell alle Variablen separat zu manipulieren und eine Aussage über das Modell als Ganzes zu treffen. Yzer et al. (1998) haben den Einfluss der Komponenten Vulnerabilität und Selbstwirksamkeitserwartung auf die Schutzmotivation im experimentellen Design getestet. Dazu wurden in einem 2x2 Design durch das Lesen von Texten das Empfinden der Bedrohung und die Selbstwirksamkeitserwartung manipuliert, wobei die Erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartung hier besser gelang. Die Autoren konnten feststellen, dass wenn die Selbstwirksamkeitserwartung niedrig war, die Höhe der Vulnerabilität unbedeutend wurde und keine Schutzmotivation gebildet wurde. Bei hoher Selbstwirksamkeitserwartung jedoch kam es eher zur Bildung einer Schutzmotivation, insbesondere in Interaktion mit einer hohen Vulnerabilität. In einem

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

metaanalytischen Review von Milne et al. (2002) wird von den Autor:innen der Schluss gezogen, dass die PMT zwar nützlich ist, um kurzfristiges Verhalten vorherzusagen, der Wert jedoch abnimmt, wenn es um die Vorhersage von weiter in der Zukunft liegendem Verhalten geht. Auch erwies sich die Bewältigungseinschätzung als wichtiger als die Bedrohungseinschätzung und innerhalb der Bewältigungseinschätzung war die Selbstwirksamkeitserwartung der stärkste Prädiktor. Im Gegensatz zu Untersuchungen mit korrelativem Design haben Plotnikoff et al. (2010) die PMT mittels Strukturgleichungsmodell bei 2.311 Patienten mit Typ I oder Typ II Diabetes mellitus bezüglich physischer Aktivität in einer 6-monatigen Längsschnittstudie untersucht. Sie fanden einen adäquaten Modellfit und auch hier stellte sich Selbstwirksamkeitserwartung als bedeutenderer Prädiktor als die Handlungswirksamkeit heraus. Ebenso gab es einen Bezug zwischen Schweregrad und Bildung einer Schutzmotivation, hingegen keinen bezüglich der Vulnerabilität.

6.2.3 Die PMT aktuell

Auch wenn einige Versuche unternommen wurden, die Gültigkeit der PMT anhand von Strukturgleichungsmodellen zu überprüfen, ist das Modell insgesamt recht komplex. Die häufigsten Anwendungen finden sich im Bereich Krankheitsprävention und Reduktion des Alkoholkonsums (Knoll et al., 2013).

6.3 Theorie des geplanten Verhaltens (Theory of Planned Behavior, TPB)

Die TPB von Ajzen (1985) stammt ursprünglich aus der Sozialpsychologie, wird jedoch häufig in der Gesundheitspsychologie für die Vorhersage von Gesundheits- beziehungsweise Risikoverhalten genutzt. Sie ist eine Erweiterung der Theorie der Handlungsveranlassung beziehungsweise Theorie des überlegten Handelns (engl.: Theory of reasoned action; Fishbein & Ajzen, 1980), welche die Erklärung der Beziehungen zwischen Einstellungen und Verhalten beansprucht. Kernelement der Theorie des geplanten Verhaltens ist die Intention, welche als Prädiktor für Verhalten dienen soll. Definiert wird Intention in dem Modell als bewusste Entscheidung, ein bestimmtes Verhalten auszuführen. Einfluss auf die Intention nehmen die Einstellung, die subjektive Norm sowie die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Auch wird die TPB den kontinuierlichen Prädiktionsmodellen zugeordnet.

6.3.1 Modellkomponenten der TPB

Die *Einstellung* gegenüber dem Verhalten resultiert dabei aus den *Erwartungen der Verhaltenskonsequenz* (z. B. „Es ist gesund mit dem Rauchen aufzuhören“).

Die *normativen Überzeugungen* wichtiger Bezugsgruppen oder Bezugspersonen („Mein Ehepartner erwartet von mir, dass ich aufhöre zu rauchen“) führen zur *subjektiven Norm*. Die explizite Berücksichtigung subjektiver Normen ist eine Besonderheit in den Theorien zum Gesundheitsverhalten (Weinstein, 1993).

Die *wahrgenommene Verhaltenskontrolle* unterscheidet letztendlich die Theorie des geplanten Verhaltens von der Theorie der Handlungsveranlassung und stellt eine Erweiterung dieser dar. *Verhaltenskontrolle* entspringt dabei den *Kontrollüberzeugungen (*„Es ist sehr gut möglich, mit dem Rauchen aufzuhören“). Damit ist die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, insbesondere die Komponente der Kontrollüberzeugung dem Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung von Bandura sehr ähnlich (Selbstwirksamkeitserwartung: „Ich bin mir sicher, regelmäßig Kondome zu benutzen“; Kontrollüberzeugung: „Ich habe die Kontrolle, in

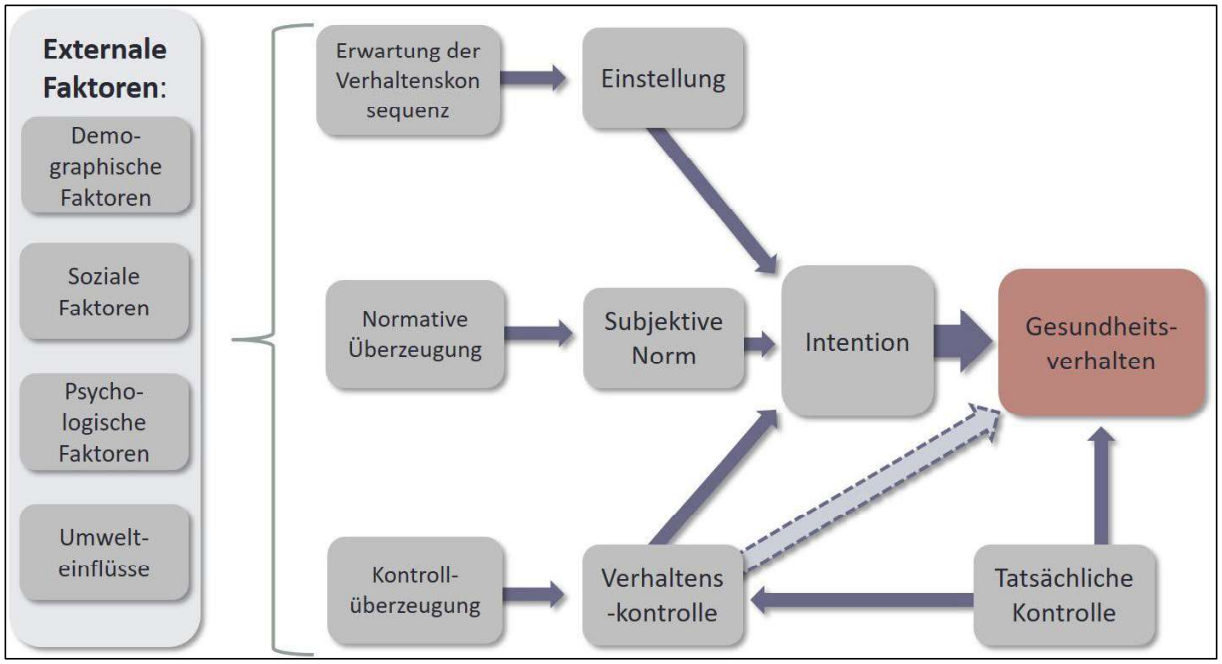
Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Zukunft regelmäßig Kondome zu benutzen", vgl. Lippke & Renneberg, 2006, S. 41), ist jedoch breiter gefasst.

Das Zusammenspiel der verschiedenen Prädiktoren, die das Gesundheitsverhalten vorhersagen, findet sich in Abbildung 6.4.

Abbildung 6.4

Theorie des geplanten Verhaltens



6.3.2 Operationalisierung der TPB

Ajzen und Fishbein (1977) selber weisen darauf hin, dass die verschiedenen Komponenten jeweils nur latente Variablen darstellen, die durch manifeste Variablen erfasst werden müssen und schlagen in diesem Zuge das Vorgehen nach dem TACT- oder Korrespondenzprinzip vor, die das vorherzusagende Verhalten genau skizzieren. *T*arget (Zielelement) beinhaltet das Ziel des Verhaltens, *A*ction (Handlungselement) umfasst, welches explizite Verhalten untersucht werden soll, *C*ontext (Kontextelement) bezieht sich auf den Bezugsrahmen, in dem das Verhalten ausgeführt werden soll und *T*ime (Zeitelement) ist der Zeitpunkt, zu dem das Verhalten ausgeführt werden soll. Dabei soll die Messung der verschiedenen Prädiktoren in Übereinstimmung auf eben dieses Verhalten operationalisiert werden. Soll beispielsweise das Verhalten bezüglich kontinuierlicher physischer Aktivität vorhergesagt werden, so könnte dies anhand der TACT-Prinzipien wie folgt operationalisiert sein: Das Handlungselement ist „dreimal die Woche joggen gehen", das Zielelement „eine Strecke von 5 km", das Zeitelement „im nächsten halben Jahr" und der Kontext könnte „bei allen Wetterbedingungen" sein. Ein Beispiel für die Messung der verschiedenen Komponenten der TPB findet sich in Abbildung 6.5.

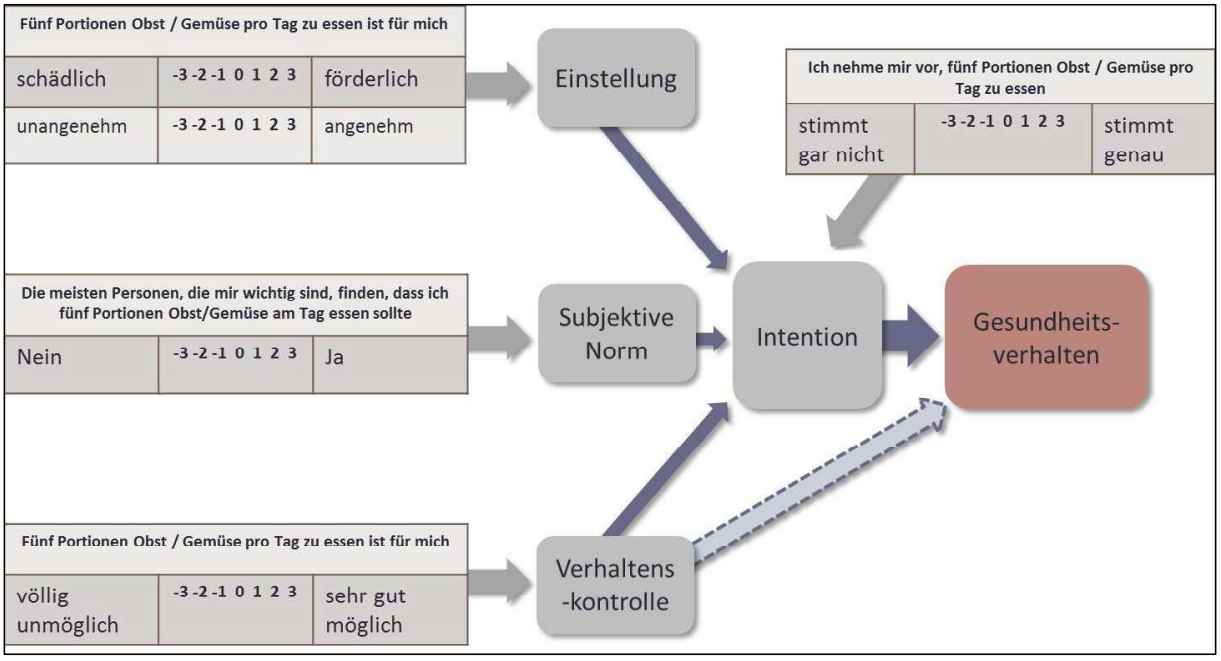
Die Beispiele in Abbildung 6.5 zeigen eine direkte Operationalisierung der Variablen *Einstellung*, *subjektive Norm* und *Verhaltenskontrolle*, wie sie im Untersuchungsdesign meist angewandt wird. Eine indirekte Erfassung dieser Komponenten von zum Beispiel *Verhaltenskontrolle* über *Kontrollüberzeugungen* und *wahrgenommene Barrieren/Ressourcen* könnte lauten: „Da ich Obst und Gemüse nicht gerne mag, fällt es mit schwer, fünf Portionen täglich zu essen; stimmt/stimmt nicht" (Kontrollüberzeugung) und „Dass ich Obst und Gemüse

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

nicht gerne mag, macht es viel schwieriger/viel einfacher für mich, fünf Portionen davon täglich zu essen." (wahrgenommene Barrieren) (vgl. Knoll et al., 2013, S. 37f).

Abbildung 6.5

Operationalisierung der Modellkomponenten im direkt angewandten Setting. Aus Knoll et al., 2013, S. 37f



6.3.3 Befunde zur TPB

Die TPB war Gegenstand zahlreicher empirischer Untersuchungen und gehört über die Gesundheitspsychologie hinaus zu den bekanntesten Modellen für die Vorhersage von Verhalten. Ein Review von Hardeman et al. (2002), das insgesamt 30 Publikationen mit 24 verschiedenen Forschungsdesigns umfasst, kam zu dem Schluss, dass aufgrund der kleinen Effektstärken der tatsächlichen Verhaltensänderung keine hinreichende Unterstützung für die Gültigkeit der Theorie gefunden werden konnte. Auch McEachan et al. (2011), die 237 Studien meta-analytisch ausgewertet haben, stellten fest, dass Intention lediglich 19.3 % der Variabilität im Gesundheitsverhalten erklärt. Die Vorhersagekraft sank weiter, wenn es sich um Studien mit einem Längsschnittdesign handelte und das Gesundheitsverhalten nicht anhand eines Selbstberichts erhoben wurde.

6.3.4 Die TPB aktuell: Die Debatte um den Ruhestand

Eine Debatte darüber, ob die TPB, nachdem sie viele Jahre essenziell für Forschung und Praxis war und der Psychologie wertvolle Erkenntnisse geliefert hat, „in den Ruhestand" geschickt werden sollte, wurde, unter anderem auf diesen Ergebnissen basierend, von Sniehotta et al. (2014) ausgelöst. Die Autor:innen bemängeln, dass die TPB nicht nur unzureichend für die Vorhersage von Gesundheitsverhalten sei, sondern dass die postulierten Mediatoreffekte (z. B. soll Intention den Zusammenhang zwischen Einstellung, subjektiver Norm und Verhaltenskontrolle einerseits und Gesundheitsverhalten andererseits mediieren) nicht durch die Empirie gestützt und sogar teilweise widerlegt seien. Sniehotta et al. (2014)betonen, dass die Aufrechterhaltung der TPB die Entwicklung weiterer Theorien, die weniger allgemein, aber dafür empirisch abgesichert sind und eine Antwort auf die Frage nach dem „warum" liefern, blockieren würde. Weiterhin

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

biete die TPB insgesamt wenige Implikationen für Interventionen und sei sehr „statisch". Der Entwickler der TPB, Icek Ajzen (2015), kommentierte hierauf, die TPB sei häufig falsch oder nur unzureichend verstanden worden. So sei die TPB nicht statisch, sondern weist einen dynamischen Charakter auf, da sie über Feedbackschleifen verfüge (z. B. können unerwartete positive oder negative Konsequenzen der Ausübung eines bestimmten Verhaltens sich auf die Bewertung der Verhaltenskonsequenz, die normativen Überzeugungen sowie die Kontrollüberzeugungen auswirken, die wiederum Einfluss auf die Intentionen haben), die zugunsten der Übersichtlichkeit nur selten in Abbildungen zu finden seien. Ebenso seien bei der Anwendung des Modells in verschiedenen Studien häufig Inventare mit 3-4 Items zu Erfassung der verschiedenen Faktoren der Theorie eingesetzt worden, die keine hinreichende Validität besitzen. Meta-Analysen, die sich mit der TPB beschäftigen, beinhalten ebendiese, laut Ajzen, unzulänglichen Studien. Daher sei die gefundene Varianzaufklärung von Gesundheitsverhalten durch die TPB in der Literatur geschmälert. Schließlich sei bei den von Sniehotta et al. (2014) aufgelisteten alternativen Modellen ebenso nicht klar, in welchen Punkten diese einen Vorteil gegenüber der TPB besitzen. Die Autor:innen würden die langjährige Arbeit unterschätzen, die es braucht, einen profunden Ansatz zur Verhaltensvorhersage zu entwickeln(Ajzen, 2015).

Nichtsdestotrotz wurde die Kritik von Sniehotta et al. (2014) von einigen bedeutenden Autor:innen der Gesundheitspsychologie gestützt. Beispielsweise betontSchwarzer (2015), dass die ständigen Erweiterungen der TPB einen deutlichen Nachteil der Theorie aufzeigen: Viele Personen, die eine starke Intention besitzen, üben kein Gesundheitsverhalten aus (siehe Abschnitt 6.5). Demgegenüber betonen andere Autor:innen (z. B. Conner, 2015), dass mit Hilfe der TPB zumindest ein Teil der Varianz am Gesundheitsverhalten erklärt werden kann und daher die Theorie wichtige Schlüsselkomponenten diesbezüglich identifiziert. So sollte laut Conner (2015) die Theorie nicht aufgegeben werden, da es der bessere Weg sei, die Weiterentwicklung solcher bestehenden Theorien, die bereits in vielen Settings getestet wurden, voranzutreiben. Andere Forschende bezeichnen das Statement historische Theorien „in die Rente zu schicken" hingegen als längst überfällig (Ogden, 2015) oder fügen der Kritik von Sniehotta et al. (2014) weitere Argumente hinzu, wie der geringen Beachtung des emotionalen Erlebens im Kontext des Gesundheitsverhaltens (z. B. Trafimow, 2015). Letztlich, soSchwarzer (2015), werde die TPB natürlich nicht einfach „in Rente" geschickt werden können und wahrscheinlich noch lange aktiv bleiben. Eine Ermutigung neue Theorien zu kreieren und bekanntzumachen, die bedeutsame Komponenten wie Habituation, automatische Prozesse, Verhaltensregulationsstrategien oder emotionale Urteilsfällung beinhalten, stammt von Rhodes (2015) in seinem Kommentar: „Will new theories (and theoreticians) please stand up?".

6.4 Sozial-kognitive Theorie (Social Cognitive Theory, SCT)

Das zentrale Element der SCT nach Bandura (1986) ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Demnach wird eine erfolgreiche Verhaltensänderung durchgeführt, wenn Personen über eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung verfügen. Die Selbstwirksamkeitserwartung wird in diesem Kontext als Einschätzung der eigenen Fähigkeiten angesehen, ein Verhalten auch bei bestehenden Barrieren auszuführen. Auch die SCT ist den kontinuierlichen Prädiktionsmodellen zuzuordnen.

6.4.1 Modellkomponenten der SCT (1)

Laut Bandura (1986)sind vier Quellen im Wesentlichen für den Aufbau von *Selbstwirksamkeitserwartung* verantwortlich:

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Erfolgreiche Erfahrung. Der wichtigste Faktor hier ist bereits eine erfolgreiche Handlung ausgeführt zu haben, die der anstehenden Handlung ähnelt. Hat eine Person das Ziel mit dem Rauchen aufzuhören, so könnte eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung daraus resultieren, dass sie dies vorher bereits einmal geschafft hat. Dabei ist weiterhin entscheidend, dass die Person ihre erfolgreichen zurückliegenden Handlungen internal attribuiert (siehe Exkurs A Attributionstheorien). Dies bedeutet in dem aufgeführten Beispiel, dass die Person denkt, sie habe es aus eigener Stärke geschafft und nicht aufgrund äußerer Umstände, zum Beispiel, weil der Lebenspartner auch aufgehört hat zu rauchen.

Stellvertretende Erfahrung. Durch eine Erfahrung, die eine andere Person, die in einer ähnlichen Situation ist und das Verhalten erfolgreich geändert hat, kann das Zutrauen in die eigene Person wachsen. Sieht eine Person beispielsweise eine Kollegin, die als starke Raucherin seit einigen Wochen abstinent und trotzdem gut gelaunt ist, kann der Rückschluss erfolgen, dass dies auch bei der eigenen Person möglich ist.

Soziale Ermutigung (auch manchmal symbolische Erfahrung genannt). Dieser Punkt beinhaltet Zuspruch oder auch die Überzeugung anderer in die Fähigkeiten einer Person. Ist zum Beispiel ein enger Freund der festen Überzeugung, eine Person könne mit dem Rauchen aufhören und dieser Freund vermittelt dies auch glaubhaft, kann dies ebenso die Selbstwirksamkeitserwartung stärken.

Physiologische Erregung. Dieser Zustand beinhaltet die körperlichen Reaktionen. Ein bekanntes Beispiel ist das starke Herzklopfen, das man vor einem Vortrag empfindet. Je stärker das Herzklopfen, desto eher wird kognitiv der Schluss gezogen, man sei dem Ereignis nicht gewachsen. Leidet nun eine Person am zweiten Tag der Rauchentwöhnung unter starken Schweißausbrüchen, könnte sie daraus schließen, dass die Anstrengung enorm ist (und bleiben wird) und der Rauchentwöhnung auf Dauer nicht Stand gehalten werden kann. Im Kontext der Gesundheitspsychologie wird dieser Aspekt jedoch am wenigsten berücksichtigt.



Auch wenn alle Faktoren die Höhe der Selbstwirksamkeitserwartung beeinflussen, so ist der Faktor einer eigenen, erfolgreichen Erfahrung der Wichtigste.

Bandura (1977) selber betont, dass sich Selbstwirksamkeitserwartungen immer auf spezifisches Verhalten beziehen und in Bezug auf konkrete Situationsanforderungen ausgebildet werden. Personen können sich also hinsichtlich eines bestimmten Verhaltens als selbstwirksam einschätzen (regelmäßig Sporttreiben) und als nicht-selbstwirksam hinsichtlich eines anderen Verhaltens (Wahrnehmung von Vorsorgeterminen). In Bezug auf die Initiierung, Aufrechterhaltung und Wiederaufnahme von Gesundheitsverhalten sind spezifische Selbstwirksamkeitserwartungen relevant, da sie mit dem Setzen von höheren Zielen, einer vermehrten Anstrengung und einem besseren Durchhaltevermögen verbunden sind (Überblick: Maddux, 2002).

Schwarzer und Jerusalem (1999) postulieren weiterhin eine globale Selbstwirksamkeitserwartung beziehungsweise generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung, die sich als zeitstabiles Merkmal aus der Erfahrung, in verschiedenen Bereichen selbstwirksam gewesen zu sein, herausbildet. Dabei setzen sich Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung höhere Ziele, handeln schneller und sind resistenter gegen Niederlagen.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Exkurs A: Attributionstheorien

Attributionstheorien beschäftigen sich mit der Ursachenzuschreibung, die Menschen nutzen, um zu erklären, warum sie sich in einer bestimmten Situation befinden. Dabei können sie unterschiedliche Arten der Attribution nutzen, die in verschiedene Attributionsstile aufgeteilt werden. Seligman (1979) unterscheidet insgesamt drei Dimensionen von Erklärungen. Eine Dimension bezieht sich auf die Globalität-Spezifität, also ob Personen das Ereignis als allgegenwärtig oder eher als Ausnahme ansehen. Eine weitere Dimension ist die Stabilität-Variabilität, die ausdrückt inwiefern eine Person ein Ereignis als zeitlich überdauernd und unveränderlich, oder vorübergehend ansieht. Die Dimension Extern-Intern bezieht sich auf die Erklärung, ob eine Person glaubt, das Ereignis selber verursacht zu haben, oder externen Faktoren dafür die Verantwortung zuschreibt. Attributionsstile müssen immer in Verbindung zu einem Ereignis betrachtet werden, um eine Aussage über die Adaptivität zu treffen. Eine Person versucht beispielsweise eine Diät zu halten, bestellt sich aber bei einem Kinobesuch mit Freund:innen eine große Portion Popcorn. Sie kann nun global („Ich esse immer viel zu viel"), stabil („Ich werde auch in Zukunft nicht konsequent Diät halten können") und intern („Das ist meine eigene Schuld, immer wenn ich etwas Leckeres sehe, muss ich es kaufen") attribuieren. Jedoch könnte die Person auch spezifisch („Das passiert nur, wenn ich ins Kino gehe"), variabel („Das war ein einmaliger Ausrutscher") und extern („Meine Freund:innen haben mir das Popcorn unter die Nase gehalten, sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen") attribuieren. Verwendet sie den letzten Attributionsstil, wird die Personen das Ereignis eher als einmaligen Ausrutscher betrachten und mit höherer Wahrscheinlichkeit der Diät standhalten als eine Person, die dieses Ereignis als global, stabil und intern attribuiert und nicht an einen Erfolg glaubt.

Kasten 6.1. Attributionstheorien

6.4.1 Modellkomponenten der SCT (2)

Neben der Selbstwirksamkeitserwartung gibt es einen weiteren wichtigen Faktor in Banduras Modell, nämlich die *Handlungsergebniserwartung* beziehungsweise *Konsequenzerwartung*, also die Erwartung, dass ein bestimmtes Verhalten (z. B. regelmäßiges Sporttreiben) ein bestimmtes Ergebnis hervorruft beziehungsweise eine bestimmte Konsequenz hat (z. B. Gewichtsreduktion). Handlungsergebniserwartungen können entweder positiv und/oder negativ sein und kurzfristige und/oder langfristige Folgen haben. Handlungsergebniserwartungen können verschiedene Bereiche betreffen, wodurch auch deutlich wird, dass sie nicht immer eindeutig in eine Richtung gehen. Dies wird im Folgenden am Beispiel der Rauchentwöhnung deutlich gemacht:

- Physische Konsequenzen: kurzfristig bessere Atmung und Durchblutung, aber auch vermehrtes Schwitzen und Nervosität, langfristig gesenktes Krebsrisiko → gemischt
- Soziale Konsequenzen: kurz- und möglicherweise langfristig Anerkennung einiger Personen, jedoch auch mögliche soziale Ausgrenzung bei weiteren Personen → gemischt
- Selbstbewertende Konsequenzen: kurz- und langfristig Zufriedenheit und Stolz → positiv

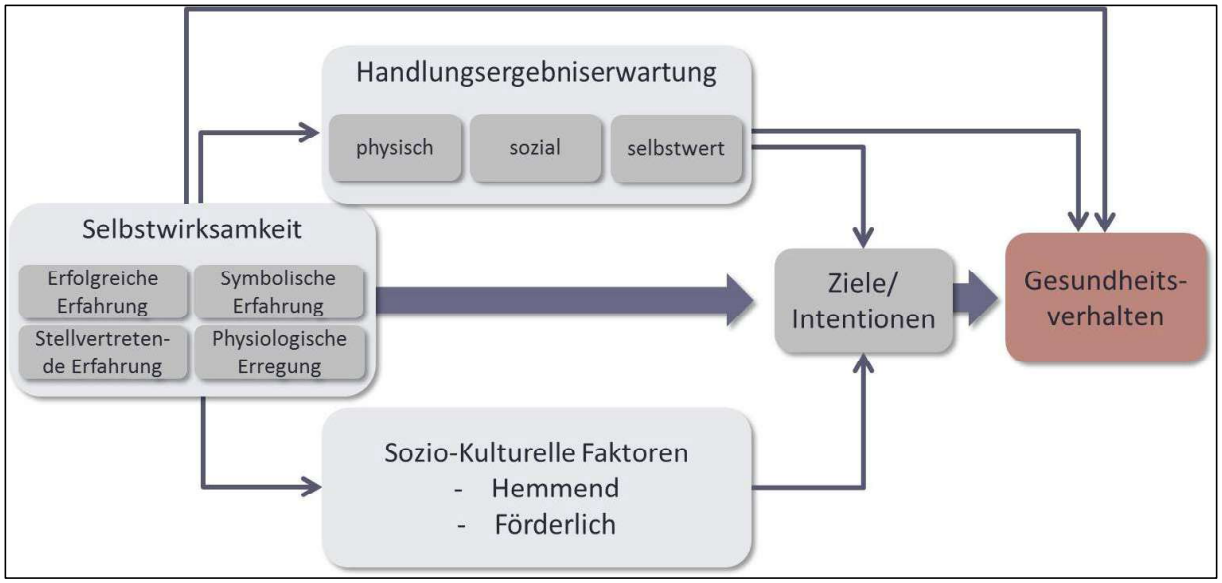
Beide Faktoren, Selbstwirksamkeitserwartung und Handlungsergebniserwartung, wirken sich auf Ziele beziehungsweise Intention, also die Absicht, ein bestimmtes Verhalten zu ändern, aus. Des Weiteren geht Bandura davon aus, dass sich eine Reihe von soziokulturellen Faktoren hemmend beziehungsweise förderlich auf Ziele und Verhalten auswirken kann. So wirkt sich bei einer Person, die aufgrund einer beruflichen Tätigkeit viel reist, eben dieser Beruf hemmend auf das Ziel und damit Verhalten, regelmäßig Sport zu treiben, aus. Wohnt eine Person hingegen neben einem Wald mit schöner Laufstrecke, kann das eine förderliche Wirkung haben. Jedoch geht Bandura auch davon aus, dass ab einer gewissen Stärke der Selbstwirksamkeitserwartung

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

soziokulturelle Faktoren kein Hindernis (oder keine hilfreiche Förderung) mehr darstellen. Die genauen Pfade finden sich in Abbildung 6.6.

Abbildung 6.6

Sozial-kognitive Theorie



6.4.2 Befunde zur SCT/Selbstwirksamkeitserwartung

Sowohl in der Anwendung als auch in der empirischen Prüfung finden zwar weniger das Modell selber, aber dafür die Komponenten der Selbstwirksamkeitserwartung und Handlungsergebniserwartung umso größeren Niederschlag. van Duyn et al. (2001) konnten beispielsweise zeigen, dass die Selbstwirksamkeitserwartung ein entscheidender Prädiktor für gesundes Ernährungsverhalten und Gewichtskontrolle darstellt. Weitere robuste Zusammenhänge wurden mit Hilfe von Meta-Analysen für die Bereiche Alkoholabstinenz (Forcehimes & Tonigan, 2008) und Rauchentwöhnung (Gwaltney et al., 2009) gefunden. Zudem bietet die Theorie verschiedene Ansatzpunkte zur Erhöhung von Selbstwirksamkeitserwartungen, zum Beispiel können große Ziele, wie die Umstellung der Ernährung, in viele kleine Ziele unterteilt werden. So könnte zunächst der Austausch von zuckerhaltigen Getränken durch Wasser geschehen und, wenn dies einige Wochen durchgehalten wurde - also eine erfolgreiche Erfahrung stattgefunden hat -, das nächste Ziel gesetzt werden.

6.4.3 SCT und Selbstwirksamkeitserwartung aktuell – Eine kritische Perspektive zur Operationalisierung von Selbstwirksamkeitserwartung

Selbstwirksamkeitserwartung hat sich in vielen Bereichen als robuster Prädiktor für die Vorhersage von Gesundheitsverhaltensänderungen erwiesen und stellt damit ein zentrales Konzept in Theorien zum Gesundheitsverhalten dar. Selbstwirksamkeitserwartung bezieht sich dabei auf die Einschätzung persönlicher Kompetenzen in Bezug auf Anforderungssituationen, also inwieweit eine Person davon überzeugt ist, in einer bestimmten Situation ein bestimmtes Verhalten ausführen zu können. Damit kann Selbstwirksamkeitserwartung zur Erklärung beitragen, *weshalb* eine Person motiviert ist, ein bestimmtes Verhalten auszuüben. Ein weiterer wichtiger Faktor in der sozial-kognitiven Theorie ist laut Bandura die Handlungsergebniserwartung, also die Erwartung, welche Konsequenz ein Verhalten hat, zum

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Beispiel eine bessere körperliche Konstitution von Zigarettenabstinenz. Dieser Faktor ist laut Theorie unabhängig von der Selbstwirksamkeitserwartung.

Weniger dem theoretischen Konzept an sich, aber der Operationalisierung von Selbstwirksamkeitserwartung in vielen Untersuchungen stehen Williams und Rhodes (2016) kritisch gegenüber. Sie stellten sich die Frage, ob in Selbstberichten zur Erfassung von Selbstwirksamkeitserwartung diese nicht als Determinante von Motivation, sondern eher die Motivation an sich reflektiert wird. Williams und Rhodes (2016) gehen in ihrer Argumentation auf Kirsch (1995) zurück, der dies sehr anschaulich an einem Beispiel illustriert. Selbstwirksamkeitserwartung soll laut Definition die Einschätzung der eigenen Kompetenzen bezüglich der Ausübung eines bestimmten Verhaltens darstellen, also inwieweit eine Person sich in der Lage fühlt, ein bestimmtes Verhalten ausführen zu können. Kirsch (1995) selber stellt dem das Argument entgegen, wie man erwägen würde zu antworten, wenn man einen Fragebogen mit folgenden Fragen beantworten würde: „Könntest du einen lebenden Wurm essen?", „Könntest du auf einer Beerdigung laut lachen?" oder „Könntest du ein Baby-Kätzchen umbringen?". Viele Personen würden auf diese Fragen mit „Nein" antworten, da sie Ekel, Scham oder starke Schuldgefühle entwickeln würden. Sie sind demnach nicht motiviert, diese Handlung auszuführen. Dieser Punkt hat jedoch nichts damit zu tun, ob sie sich in der Lage fühlen würden, dieses Verhalten ausführen zu können. Letztlich kann es demnach sein, so Williams und Rhodes (2016), dass Selbstwirksamkeitserwartung deshalb einen so guten Prädiktor darstellt, da eher die generelle Motivation gemessen wird und Personen häufig Handlungen ausführen, zu denen sie motiviert sind. Auch würden eventuell mehrere Personen die Frage, ob sie einen lebenden Wurm essen können mit „Ja" beantworten, wenn sie eine Belohnung bekämen, also die Motivation erhöht würde. Laut Definition ist die Selbstwirksamkeitserwartung aber der Handlungsergebniserwartung vorangestellt, demnach beeinflusst die Selbstwirksamkeitserwartung Motivation und unter Umständen auch die Einschätzung der Handlungsergebnisse, jedoch nicht umgekehrt. Williams und Rhodes (2016) listen folgend eine Reihe an Studien aus der Gesundheitspsychologie auf, bei denen eine gezielte Änderung des Handlungsergebnisses höhere Werte in der Selbstwirksamkeitserwartung zur Folge hatten. Nun könnte ein Argument lauten, dass das Konstrukt trotzdem einen guten Prädiktor darstellt und es deshalb weiter genutzt werden solle. Möchte man aber neben der generellen Motivation Mechanismen finden, die Gesundheitsverhalten erklären, könnte sich dies laut der Autoren als problematisch darstellen. Williams und Rhodes (2016) kommen nicht zu dem Schluss, das Konstrukt sei vollends zu verwerfen, sondern betonen die mögliche Konfundierung mit dem Konstrukt Motivation und schlagen vor, sich im Kontext des Gesundheitsverhaltens eher auf eben dieses Konstrukt zu konzentrieren. Eine explizite Antwort auf den Artikel gaben jüngst Schwarzer und McAuley (2016). Die Kritik der enormen Konfundierung sei gerechtfertigt, jedoch ist Konfundierung nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die menschliche Natur ist nicht orthogonal, vielmehr ist alles miteinander verwoben. Zudem wurde bei einer Vielzahl von Studien Selbstwirksamkeitserwartung und Motivation separat erfasst. Die Korrelationen zwischen beiden Konstrukten fallen jedoch maximal moderat aus, was darauf hindeutet, dass es sich um zwei verschiedene Konstrukte handelt. Das Besondere an dem Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung sei die Kombination aus Kompetenz, zeitlicher Perspektive und Verhalten.

Exkurs B: Motivation und Volition

Als Motivation wird das Streben eines Menschen nach Zielen oder Zielobjekten verstanden. Motivation erklärt, warum Menschen ein bestimmtes Verhalten ausüben. Gründe hierfür können

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

intrinsisch (z. B. Neugier, Erfolgserwartung) oder extrinsisch (z. B. Zwang, Belohnung) sein. Bei einer intrinsischen Motivation stimmen Handlung und Ziel thematisch überein. Dies könnte zum Beispiel das Wahrnehmen eines Vorsorgetermins beim Zahnarzt sein (Handlung), um gesunde Zähne zu behalten (Ziel). Ein extrinsisches Ziel wäre in diesem Beispiel der Stempel im Bonusheft aus Sorge, bestimmte Leistungen nicht mehr gewährt zu bekommen. Volition bezeichnet dabei die Umsetzung von Motiven und Zielen in konkrete Ergebnisse durch Verhaltensausführung oder Handlungen. Während Motivation also das Streben nach bestimmten Zielen darstellt, umfasst Volition die Handlungen, die zum Erreichen dieser Ziele getätigt werden müssen (Schmalt et al., 2009). Ein zentraler Aspekt bezüglich des Gesundheitsverhaltens ist hierbei die Planung, wie ein Ziel erreicht und welche Barrieren möglicherweise überwunden werden müssen. Hierzu erfordert es gewisse Umsetzungskompetenzen, welche die Fokussierung von Aufmerksamkeit, Regulation von Emotionen oder Selbstwirksamkeitserwartung beinhalten können (siehe Abschnitt 6.5).

Kasten 6.2. Motivation und Volition

6.5 Intentions-Verhaltens-Lücke (Intention-Behaviour Gap, IBG)



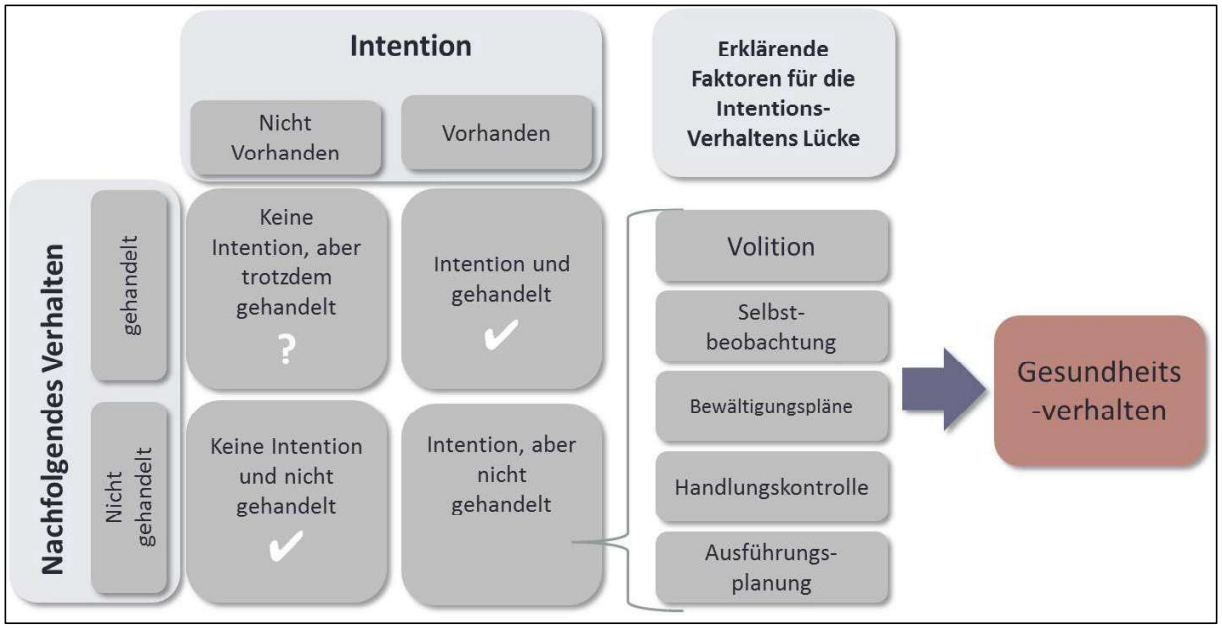
In kontinuierlichen oder motivationalen Modellen wird die Stärke der Intention mit der Ausführung von Gesundheitsverhalten assoziiert. Jedoch werden im tatsächlichen Leben auch starke Intentionen häufig nicht in aktives Gesundheitsverhalten umgesetzt („Ich möchte gern Sport treiben, tue es aber nicht"). Dies zeigt sich auch empirisch: Werden lediglich Intentionen zur Vorhersage von Verhalten genutzt, erklären diese meist nur 20 % der Varianz im Verhalten (Sheeran, 2002). Somit scheint vielen kontinuierlichen Prädiktionsmodellen etwas Entscheidendes zu fehlen, da es eine Lücke zwischen den Intentionen und dem Verhalten gibt, die nicht erklärt wird. Volitionale Modelle und Konzepte des Gesundheitsverhaltens beschäftigen sich mit eben diesem in der Gesundheitspsychologie als Intention-Verhaltens-Lücke bekannten Phänomen. Der Unterschied zwischen motivationalen und volitionalen Modellen zum Gesundheitsverhalten lässt sich auch am Rubikonmodell von Heckhausen (1989) illustrieren. Dabei gilt die Überschreitung des Rubikons als kritisches Element, nachdem es „kein Zurück mehr gibt". Die Bildung einer Intention stellt die Überquerung des Rubikons dar. Motivationale Modelle beschäftigen sich vornehmlich mit allem, was bis zu eben dieser Intentionsbildung passiert, während volitionale Modelle danach ansetzen und versuchen Faktoren zu identifizieren, die einen Erklärungsansatz dafür liefern, unter welchen Bedingungen Intentionen in Verhalten umgesetzt werden.

Wenn eine Intention zum Handeln vorhanden ist, gibt es zwei mögliche Ausgänge: es wird tatsächlich gehandelt oder es wird trotz Intention nicht gehandelt. Demgegenüber können bei Personen ohne Intention ebenso keine Handlungen stattfinden oder aber es kann ohne Intention gehandelt werden. Bei den Personen, die eine Intention haben und auch handeln beziehungsweise die keine Intention zum Handeln haben und dies auch nicht tun, besteht keine Intentions-Verhaltens-Lücke. Verantwortlich für die gefundenen Diskrepanzen sind demnach die beiden anderen Gruppen, wobei die Personen, die eine Intention besitzen und nicht handeln, die deutliche Mehrheit darstellen. Diese vier Ausprägungen haben Orbell und Sheeran (1998) in einer Vierfeldertafel dargestellt (siehe Abbildung 6.7).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 6.7

Vierfeldertafel der Intentions-Verhaltens-Lücke nach Orbell & Sheeran (1998)



6.5.1 Befunde zur IBG

Rhodes und de Bruijn (2013) haben anhand einer Meta-Analyse versucht zu prüfen, wie groß die IBG in Bezug auf die Ausübung von physischem Verhalten ist. Dazu bezogen sie 10 Studien in die Analyse mit ein. Sie fanden, dass Personen, die eine Intention besitzen und auch handeln die größte Gruppe mit 42 %[5] ausmachten, während Personen, die keine Intention besitzen und auch nicht handeln 21 % der Gesamtstichprobe darstellten. Weiterhin hatten 36 % der Personen eine Intention, handelten aber nicht und 2 % zeigten das umgekehrte Muster, da sie keine Intention hatten, aber handelten. Betrachtet man alle Personen, die eine Intention besitzen, so zeigt sich, dass 46 % ebendieser Personen nicht handeln. Diese Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit der Forschung nach Faktoren, die für die IBG verantwortlich sind, denn daraus lassen sich dann konkrete Handlungs- und Interventionsmaßnahmen ableiten.

6.5.2 Mögliche Faktoren zur Erklärung der IBG

Ein möglicher Grund für die Lücke zwischen vorhandenen Intentionen und Verhalten kann die *Messmethodik* betreffen, wie die Konkretheit beziehungsweise die Operationalisierung der Variablen (siehe hierzu auch Abschnitt 6.3.2).

Kuhl (2001) schlägt als erklärende Variable für die IBG die *individuelle Handlungskontrolle* vor und unterscheidet zwischen lage- und handlungsorientierten Personen. Dabei sind Personen mit hoher Handlungsorientierung auch bei zurückliegendem Misserfolg bestrebt, die Lücke zwischen Ziel- und Ist-Zustand zu schließen. Lageorientierte Menschen hingegen richten ihre Energie auf die Analyse der aktuellen Lage, was sie in ihrer Handlungsfähigkeit ausbremst.

Eine weitere erklärende Variable ist die Fähigkeit zur *Handlungsplanung* oder *Ausführungsplanung*. Wenn die Zielintention beispielsweise beinhaltet das Gewicht zu reduzieren, wäre eine Ausführungsplanung „Wenn ich heute Abend fertig bin mit dem Essen, dann verzichte ich auf den Nachtisch". Die Ausführungsplanung mit der „Wenn-Dann-Komponente" ist auch

[5] Die Ergebnisse ergeben in der Summe – höchstwahrscheinlich aufgrund von Rundungsungenauigkeiten – 101 %.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

unter dem Begriff Implementierungs-Intentionen bekannt (Gollwitzer, 1999). Implementierungs-Intentionen beschreiben noch genauer, in welchen Situationen welches Verhalten in welcher Form ausgeführt wird („Wenn es heute Abend noch hell ist, werde ich Joggen gehen, wenn es nach Feierabend schon dunkel ist, werde ich ins Fitnessstudio gehen"). In einer Studie von Verplanken und Faes (1999) wurde eine Gruppe von Studierenden mit der Motivation zu gesunder Ernährung gebeten, ihr Essverhalten für die kommende Woche zu planen, während eine andere Gruppe mit vergleichbarer Motivation, sich gesund zu ernähren, keine solche Instruktion bekam. Das Ergebnis der Studie war, dass sich die Gruppe, die ihr Essverhalten plante, insgesamt gesünder ernährte. Personen, die über konkrete Ausführungspläne verfügen, zeigen somit eine höhere Wahrscheinlichkeit, das intendierte Verhalten auszuführen.

Bewältigungspläne sind gegenüber Ausführungsplänen dafür gedacht, mögliche Probleme bei der Ausführung eines entsprechenden Verhaltens im Vorfeld vorherzusehen und sich eine Lösung hierfür zu erarbeiten („Wenn ich mich sportlich betätigen möchte, es aber zu heiß von den Temperaturen ist, werde ich stattdessen schwimmen gehen" oder „Wenn ich aufhören möchte zu rauchen, auf einem sozialen Ereignis aber in Versuchung gerate, werde ich stattdessen ein scharfes Minzbonbon essen"). In einer Studie von Sniehotta et al. (2006) wurde der zusätzliche Effekt von Bewältigungsplänen bei Herzpatient:innen untersucht, die sich sportlich betätigen wollten. Patient:innen, die sich neben Ausführungsplänen („Wann und wo werde ich mich sportlich betätigen") auch noch mit den Hindernissen beschäftigt hatten („Was unternehme ich bei möglichen Rückschlägen"), zeigten nach vier Monaten eine höhere sportliche Aktivität.

Weiterhin konnte der Faktor *Selbstbeobachtung* als „Lückenfüller" gefunden werden. So zeigte sich in einer Studie von Carter et al. (2013), das smartphonebasierte Selbstbeobachtung die Adhärenz und den Erfolg beim Abnehmen erhöht, wobei Probanden, die Selbstbeobachtung durch das Smartphone betrieben fast doppelt so viel abnahmen, wie die Personen, die Papiertagebücher nutzten (siehe auch Kurs 1, Kapitel 8 „Ernährung und Essverhalten").

6.5.3 Die IBG aktuell

Die IBG an sich zeigt anhand der Vierfeldertafel die verschiedenen Gruppen bezüglich Intention und Verhalten auf und deuten damit zunächst nicht auf eine direkte Relevanz für die Praxis hin. Insgesamt wurden über die Jahre von unterschiedlichen Forschungsgruppen unterschiedliche Faktoren genannt, die die Diskrepanz zwischen vorhandener Intention und nicht ausgeführtem Verhalten erklären sollten. Viele dieser Ansätze trugen zur Überbrückung der Lücke zwischen vorhandenen Intentionen und Verhalten bei und sind daher auch für die Praxis relevant. Dabei handelt es sich bei den hier aufgeführten Faktoren größtenteils um kognitive Variablen. Jedoch konnte auch ein Einfluss affektiver Variablen bei zielgerichtetem Verhalten nachgewiesen werden (Bagozzi & Pieters, 1998). Den Einfluss von emotionalen Zuständen in diesem Bereich zu untersuchen bleibt ein für die Zukunft offenes Forschungsfeld. Insgesamt wenig Aufmerksamkeit wurde bisher der Gruppe geschenkt, die keine Intention besitzen, jedoch trotzdem ein gewisses Maß an Gesundheitsverhalten zeigen.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

6.6 Transtheoretisches Modell der Verhaltensänderung (Transtheoretical Model of behavior change, TTM)



Das TTM von Prochaska und DiClemente (1982) ist ursprünglich ein Modell, welches die verschiedenen Stadien bei der Rauchentwöhnung erklären sollte. Dementsprechend handelt es sich auch um ein Stadien- beziehungsweise Stufenmodell. „Transtheoretisch" begründet sich dadurch, dass das Modell Elemente aus verschiedenen bestehenden Theorien und Modellen einbezieht, da die Autoren davon ausgehen, dass nicht eine Theorie allein in der Lage ist, die Komplexität der Verhaltensänderung abzubilden. Weitere Annahmen des Modells beziehen sich unter anderem darauf, dass

- die Verhaltensänderung ein Prozess ist, der stufenförmig über die Zeit verläuft,
- Personen ohne gezielte Interventionen auf den frühen Stufen verharren würden,
- Personen sich bezüglich einer spezifischen Verhaltensweise nicht auf zwei oder mehreren Stufen gleichzeitig befinden können,
- die Intervention auf die verschiedenen Stufen zugeschnitten sein muss.

6.6.1 Modellkomponenten des TTM

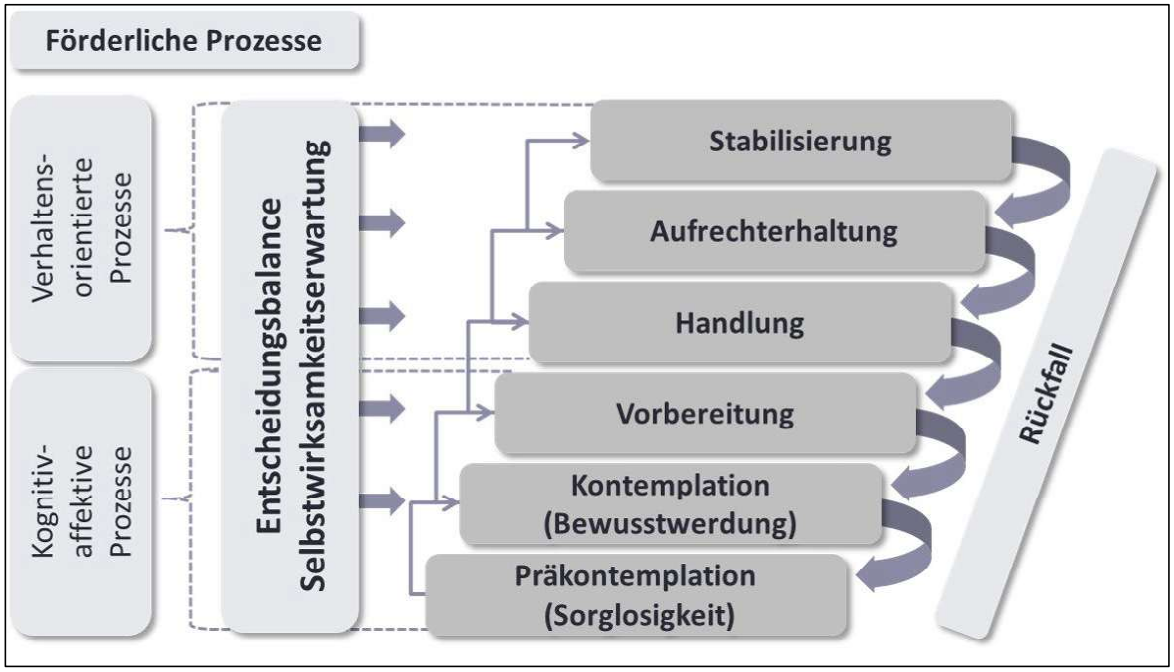
Insgesamt beinhaltet das Modell sechs diskrete, qualitativ unterschiedliche Stufen (siehe Abbildung 6.8). Die Zuordnung von Personen auf eine bestimmte Stufe bezüglich eines Gesundheitsverhaltens geschieht aufgrund des derzeitig gezeigten Gesundheitsverhaltens in Kombination mit der Motivation, zukünftig dieses Gesundheitsverhalten auszuführen. Dabei beginnt das TTM mit der 1. Stufe *Präkontemplation* (oder auch Sorglosigkeit/Absichtslosigkeit). Personen, die sich auf dieser Stufe befinden, zeigen keinerlei Änderungsbereitschaft gegenüber ihrem gesundheitsgefährdenden Verhalten. Gründe hierfür könnten ein Mangel an Informationen sein, die möglicherweise auch deswegen ausgeblendet werden, weil die Wahrscheinlichkeit, das Verhalten zu verändern, als gering eingeschätzt wird. Eine Operationalisierung dieser Stufe geschieht meist mit einer Koppelung an das Zeitkriterium von sechs Monaten, in denen nicht absehbar ist, dass eine Verhaltensänderung angestrebt wird (Prochaska & Velicer, 1997). Der Schritt auf die nächste Stufe kommt häufig durch äußere Reize zu Stande, wie beispielsweise durch die Warnung eines Arztes, dem Lesen eines Zeitungsartikels oder Gesundheitskampagnen. In der 2. Stufe *Kontemplation* (Bewusstwerdung) wägen Personen das Für und Wider einer Veränderung des gesundheitsgefährdenden Verhaltens ab, wobei eine Verhaltensänderung innerhalb der nächsten 30 Tage herbeigeführt werden soll. Jedoch werden auf dieser Stufe noch keine Intentionen gebildet oder eine konkrete Planung vorgenommen. Dies passiert in der darauffolgenden 3. Stufe *Vorbereitung*. Personen sind hier sehr motiviert eine Veränderung möglichst zeitnah durchzuführen. Damit ist diese Stufe kurzweiliger als die anderen Stufen. Das konkrete Verhalten (z. B. Beginn der Nahrungsumstellung) wird noch nicht komplett ausgeführt, jedoch können sich bereits erste Annäherungen zeigen (z. B. Verzicht auf zuckerhaltige Getränke). In der 4. Stufe *Handlung* wird das Verhalten auch für andere Personen sichtbar. Hier müssen viel Energie und Zeit investiert werden. Prochaska und DiClemente (1982), die dieses Modell insbesondere für die Suchtbekämpfung erstellt haben, gehen von einem Zeitraum aus, der ungefähr sechs Monate andauert. Auch ist auf dieser Stufe die Gefahr eines Rückfalls im besonderen Maße gegeben. Die 5. Stufe *Aufrechterhaltung* wird erreicht, wenn das veränderte Verhalten zur Routine geworden ist. Die 6. und letzte Stufe *Stabilisierung* ist dem Modell nachträglich hinzugefügt worden. Sie stammt aus der Beobachtung von Rauchenden, deren

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall über die Jahre abnimmt und unterscheidet sich von der Stufe der Aufrechterhaltung dadurch, dass Personen auf dieser Stufe das Verhalten automatisiert durchführen, also keine besondere Energie aufbringen müssen, um das Verhalten auszuüben (Prochaska et al., 1994). Sie ist jedoch nicht für alle Bereiche anwendbar, da zum Beispiel die Ausübung körperlicher Aktivität als zu instabil anzusehen ist.

Abbildung 6.8

Darstellung des transtheoretischen Modells



Prochaska et al. (1992) modifizierten in einer späteren Version das Modell dahingehend, dass die Stufen spiralförmig angesiedelt sind (in Abbildung 6.8 durch die rechts befindlichen, abwärts verlaufenden Pfeile dargestellt), was symbolisieren soll, dass Personen, bevor die endgültige Verhaltensänderung eintritt, häufig Rückschläge erleben und auf vorherige Stufen zurückfallen können.

Weiterhin existieren im TTM *förderliche Prozesse*, die sowohl kognitiv-affektive Strategien als auch verhaltensorientierte Strategien umfassen. Das Erlernen dieser Strategien soll den Aufstieg auf die nächste Stufe beziehungsweise den Verbleib auf der Stufe ohne Rückfall erleichtern. Eine Beschreibung der verschiedenen Komponenten der beiden Prozesse findet sich in Tabelle 6.2. In einer Meta-Analyse konnte Rosen (2000) nachweisen, dass die kognitiv-affektiven Prozesse eher für die frühen Stufen relevant sind, während verhaltensorientierte Prozesse eher für die späteren Stufen hilfreich sind, wobei dies auch abhängig von der Domäne der Verhaltensänderung war (z. B. trifft dieses Muster eher bei Rauchentwöhnung als bei sonstigem Substanzmittelentzug zu).

Tabelle 6.2

Prozesse der Verhaltensänderung im TTM

Kognitiv-affektive Prozesse/Strategien	Verhaltensorientierte Prozesse/Strategien
Bewusstseinserhöhung (consciousness raising) Wahrnehmung von Ursachen, Konsequenzen und möglichen Lösungswegen für das Problemverhalten wird erhöht.	Kontingenzmanagement (reinforcement) Sich selbst für erfolgreiche Veränderungen belohnen oder Rückfalle bestrafen.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Neubewertung der Umwelt (environmental reevaluation) Wahrnehmung des Einflusses des Problemverhaltens auf die Umwelt wird verändert.	Gegenkonditionierung (counterconditioning) Problemverhalten durch alternative Verhaltensweisen ersetzen.
Neubewertung der eigenen Person (self-reevaluation) Affektive und kognitive Bewertung des Selbstbilds und des Problemverhaltens wird verändert.	Hilfreiche Beziehungen (helping relationships) Offene und vertrauensvolle Beziehungen zur Unterstützung bei der Verhaltensänderung nutzen.
Emotionale Relevanz (dramatic relief) Negative Gefühle bzgl. des Problemverhaltens werden intensiviert, um eine emotionale Erleichterung im Fall einer Verhaltensänderung zu erzeugen.	Selbstbefreiung (self-liberation) Verpflichtung zu handeln und die Schaffung neuer Alternativen für das Selbst werden erhöht.
Soziale Befreiung (social liberation) Alternativen für Nicht-Problemverhalten aus der sozialen Umwelt werden verstärkt wahrgenommen.	Stimuluskontrolle (stimulus control) Reize, die das Problemverhalten auslösen, werden vermieden und Reize für alternative Verhaltensweisen werden geschaffen.

Anmerkung. Nach Prochaska et al., 2001, angelehnt an Knoll et al., 2013, S. 57.

Zudem wurden dem Modell die Entscheidungsbalance und die Selbstwirksamkeitserwartungen hinzugefügt, die darüber bestimmen, ob eine Person die Stufe wechselt. Die *Entscheidungsbalance* beschreibt dabei das Abwägen positiver und negativer Handlungs-Ergebniserwartungen beziehungsweise das Abwägen der Vor- und Nachteile. So ist der Einfluss der negativen Erwartungen in der präintentionalen Stufe höher („Wenn ich meine Ernährung umstelle, kostet mich dies viel Zeit und Geld"), während ab der Handlungsphase der Einfluss der positiven Erwartungen stärker ist („Wenn ich meine Ernährung umstelle, werde ich schlanker und gesünder"). Die Entscheidungsbalance verschiebt sich damit über die Stufen hinweg von einer negativen in eine positive Richtung. Die *Selbstwirksamkeitserwartung*, also die wahrgenommene eigene Kompetenz, Risikosituationen erfolgreich meistern zu können, stellt eine wichtige Komponente für Versuchungen dar. Operationalisiert wird sie meist über die Erfassung der Zuversicht, ein bestimmtes Verhalten trotz Barrieren zu zeigen. So konnte beispielsweise eine Metaanalyse von Marshall und Biddle (2001) zeigen, dass die Selbstwirksamkeitserwartung über die Stufen des TTM im Bereich der körperlichen Aktivität anstieg.

6.6.2 Kritik am TTM

Wie bereits in den Kernannahmen zum transtheoretischen Modell erwähnt, besteht die Annahme, Personen würden ohne Interventionen auf den ersten Stufen des Modells verharren. Werden Interventionen eingesetzt, müssen diese auf die einzelnen psychologischen Prozesse innerhalb der verschiedenen Stufen zugeschnitten werden, um das Fortschreiten auf die nächste Stufe zu ermöglichen. Dies bedeutet sowohl für die empirische Überprüfung als auch für die Praxis, dass Interventionen, die wirksam sind, um von Stufe 1 in Stufe 2 zu gelangen, unwirksam sein müssen, um von Stufe 2 in Stufe 3 zu gelangen. Dies wird auch als *matched design* bezeichnet (die Intervention „matched" nur mit der zugehörigen Stufe; bei Paarung mit einer anderen Stufe sollte ein „mismatch" entstehen). Bei einer Intervention, die nur auf eine bestimmte Stufe zugeschnitten ist, spricht man auch von einer maßgeschneiderten Intervention (engl.: tailored intervention). Allerdings können bei der experimentellen Überprüfung von sogenannten „match-mismatch"-Designs einige methodische Probleme auftreten. So erfordert es einen hohen Aufwand Störfaktoren zu berücksichtigen, die kein Teil der Untersuchung sind (z. B., dass die

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie 2013 ihre Mastektomie öffentlich machte und sich in der Folge viele Frauen zur Brustkrebsvorsorge anmeldeten). Zwar können Erfolge beziehungsweise Misserfolge von Maßnahmen verschiedener Stufen hinsichtlich der Selbstwirksamkeitserwartung, der Entscheidungsbalance und der Motivation verglichen werden, hier existieren jedoch keine empirisch begründeten Cut-offs, die als Erfolgsindikatoren für den Übergang in die nächsten Stufen dienen. Ebenso betrifft die „Willkür" das Zeitkriterium. So wird beispielsweise das Zeitkriterium von genau sechs Monaten, in denen nicht angestrebt wird, das Verhalten zu ändern, als Zuteilung für Stufe 1 herangeführt. Dies beruht jedoch nicht auf einer empirisch abgesicherten Einteilung. Hier kommt vor allem der Einwand von Schwarzer (2004) zu tragen, dass sich Individuen kontinuierlich weiterentwickeln (wie z. B. im Anstieg der Selbstwirksamkeitserwartung) und es sich daher nur um ein Pseudostufenmodell handeln könne (ein Modell, in dem kontinuierliche Variablen künstlich in verschiedene Stufen aufgeteilt werden). Weiterhin merkt Sutton (2005) an, dass soziale Prozesse in dem Modell zu wenig berücksichtigt würden.

6.6.3 Befunde zum TTM

Wie bereits erwähnt eignet sich der interindividuelle Vergleich von Personen auf verschiedenen Stufen nur bedingt für die Beurteilung der Gültigkeit des Modells. Weinstein, Rothman und Sutton (1998) schlagen neben diesem querschnittlich angelegten Vergleich weitere Strategien zur Überprüfung des Modells vor, wie zum Beispiel experimentelle Untersuchungen oder längsschnittliche Untersuchungen von Stufenübergängen oder Stufenabfolgen, wobei sie hier genauere Kriterien zur Stufendefinition festlegen. Diese Kriterien umfassen:

1. Stufen beinhalten qualitativ verschiedene und exklusive Kategorien, aufgrund derer eine Zuordnung von Personen erfolgen kann.
2. Die Stufen werden in einer bestimmten Reihenfolge durchlaufen.
3. Es existieren gleiche Barrieren für eine Verhaltensänderung für Personen auf derselben Stufe.
4. Es existieren unterschiedliche Barrieren für Personen, die sich auf unterschiedlichen Stufen befinden für eine Verhaltensänderung.

Herzog (2008)hat den Versuch unternommen, das transtheoretische Modell bezüglich der Rauchentwöhnung anhand eines systematischen Reviews mit Längsschnittstudien zu evaluieren und überprüfte, ob das TTM eben diese Kriterien erfüllt. Insgesamt konnte nicht festgestellt werden, dass das TTM den Kriterien von Weinstein und Team (1998) genügt. Ein großer Kritikpunkt war hier, dass sich die Stufen nicht als distinkte Kategorien einteilen lassen und beim Übergang der Stufen die Motivation unterschätzt würde. Auch experimentelle Studien scheinen die Gültigkeit des TTMs nicht zu stützen (für einen Überblick siehe Conner & Norman, 2005, S. 289ff). Demgegenüber stehen jedoch Befunde, wie die der Meta-Analyse von Marshall und Biddle (2001), die 91 unterschiedliche Stichproben für Interventionen im Bereich körperlicher Aktivität analysierten. Der Großteil der Studien hatte ein querschnittlich ausgelegtes Design, das zwar Erfolge der Interventionen nach einer bestimmten Zeit erfasste, die Stufen aber im between-subject Design miteinander verglich. Die Autoren fanden signifikante Unterschiede, insbesondere der Selbstwirksamkeitserwartung und der Entscheidungsbalance (hier Anzahl an Pro-Argumenten), zwischen benachbarten Stufen und nochmal signifikante Unterschiede in einem Großteil der kognitiv-affektiven und verhaltensorientierten Prozesse im Vergleich der beiden Stufen Präkontemplation und Kontemplation sowie Vorbereitung und Handlung. Die Autoren sehen diese Befunde als unterstützend für die Annahmen des Modells.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

6.6.4 Das TTM heute

Heutzutage wird das Modell von Praktikern, trotz der starken Kritik, insbesondere für die Rauchentwöhnung, aber auch für den Aufbau physischer Aktivität genutzt. Ein weiterer Bereich, in dem das Modell weitaus häufiger genutzt wird als die anderen hier aufgeführten kontinuierlichen Modelle, ist die klinische Psychologie. Ein besonderer Vorteil des Modells bleibt es weiterhin, dass durch die Maßschneiderung der Interventionen wertvolle Ressourcen gespart werden können. In jüngster Zeit diente das TTM auch zunehmend als Grundlage für die Entwicklung des Motivational Interviewing (Brinkmann, 2021; siehe auch Kurs 2, Kapitel 2 „Gesundheitskommunikation").

6.7 Das Prozessmodell präventiven Handelns (Precaution Adoption Process Model, PAPM)

Ein weiteres Stufenmodell ist das PAPM (Weinstein, 1988),welches im Laufe der Zeit vielen Revisionen unterlag. Es ähnelt in seinen Stufen sehr dem TTM, wobei im PAPM die erste Stufe nochmals unterteilt wurde.

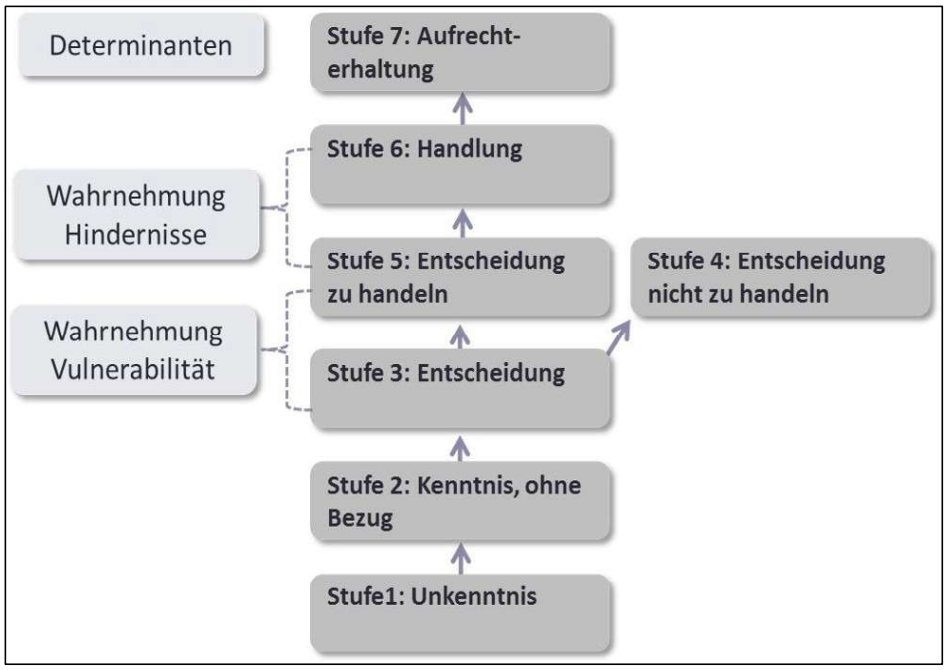
6.7.1 Modellkomponenten im PAPM

Die erste Stufe im PAPM bezeichnet die völlige Unkenntnis eines Gesundheitsverhaltens (z. B. massive Fehlernährung kann Krebs verursachen), wodurch sie sich von der ersten Stufe des TTM unterscheidet. Die zweite Stufe ist hingegen mit der ersten Stufe des TTMs vergleichbar, die Personen wissen zwar von den möglichen Konsequenzen eines Verhaltens, denken jedoch nicht weiter darüber nach. Die folgende Stufe 3 beinhaltet die Frage der Entscheidung. Personen auf dieser Stufe beschäftigen sich also mit dem Gesundheitsverhalten und treffen die Entscheidung, ob sie in diesem Fall weiterhin nicht handeln (Stufe 4) oder sich zu einer Handlung entschließen (Stufe 5). Hier findet sich ein Unterschied zum TTM, da sich die Personen bewusst gegen eine Handlung entscheiden können. Die weiteren Stufen Handlung (Stufe 6) und Aufrechterhaltung (Stufe 7) sind wiederum vergleichbar zum TTM. Ein Rückfall in eine frühere Stufe ist in dem Modell ebenso möglich, mit der Ausnahme, dass nicht auf die erste Stufe zurückgefallen werden kann, da die Kenntnis weiterhin vorhanden bleibt. Das Modell geht von mehreren Determinanten aus, die einen Aufstieg der Stufen begünstigen. Zum Beispiel spielt die Wahrnehmung persönlicher Verwundbarkeit eine zentrale Rolle für die Intentionsbildung zu einer vorbeugenden Handlung, was den Stufenübergang 3-5 charakterisiert. Der Stufenübergang 5-6, die tatsächliche Handlungsaufnahme, wird beeinflusst durch die Wahrnehmung situativer Hindernisse. Das Modell ist in Abbildung 6.9 dargestellt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 6.9

Darstellung des Prozessmodells präventiven Handelns



Das PAPM ähnelt in seinen Stufen stark dem TTM und weist dementsprechend ähnliche Implikationen für die Praxis auf und stellt sich bezüglich der Struktur denselben Vorteilen sowie auch der Kritik.

6.7.2 Befunde zum PAPM

Sniehotta et al. (2005) testeten die verschiedenen Stufen des PAPM im Querschnittsdesign an über 800 Probanden, die auf ihre Intention der Reduktion des Fleischkonsums während der BSE-Epidemie befragt wurden. Sie fanden, dass sich Personen auf Stufe 2 beispielsweise weniger vulnerabel fühlten, ein stärkeres Vertrauen in ihre Fähigkeit zur Verhaltensänderung hatten und weniger dem Gefühl der Prokrastination ausgesetzt waren als Personen auf Stufe 3 beziehungsweise 4. Auch sahen Personen auf Stufe 4 beispielsweise weniger Vorteile im gesundheitsbezogenen Handeln im Gegensatz zu den anderen Stufen. Demgegenüber verhielten sich die Selbstwirksamkeitserwartung und positive Ergebniserwartungen eher linear, was demnach für ein Pseudostufenmodell sprechen würde. Somit konnte das Stufenmodell nur teilweise gestützt werden. Eine weitere Überprüfung stammt von den Autor:innen des PAPM selber. Da Stufenmodelle von matched designs ausgehen, rekrutierten Weinstein, Lyon et al. (1998) über 1,800 Personen, die mit einem einfachen Test die Konzentration von Radongas (ein natürlich vorkommendes Gas, das Lungenkrebs verursachen kann) in ihrem eigenen Haus messen sollten, wobei sich die Teilnehmenden in einer Gegend mit erhöhter Konzentration befanden. Zunächst sahen alle Teilnehmenden ein kurzes Informationsvideo über Radongas. Das Informationsvideo diente dazu, alle Teilnehmenden bestmöglich auf denselben Kenntnisstand zu bringen. Hiernach fand eine Befragung statt, wonach zwei Gruppen von Teilnehmenden herausgefiltert wurden: diejenigen, die noch unentschlossen waren, einen Radongastest durchzuführen (Stufe 3) und diejenigen, die bereits beschlossen hatten den Test durchzuführen (Stufe 5). Teilnehmende auf den anderen Stufen wurden nicht weiter berücksichtigt. Die verbliebenen Teilnehmende bekamen randomisiert entweder a) keine Intervention, b) ein Video mit der Information über eine hohe Wahrscheinlichkeit einer erhöhten Radongaskonzentration

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

(Steigerung der Bedrohung), c) ein Video über eine Anleitung zur Messung von Radongas und Bestellformular für einen Test (Planungshilfe) oder d) beide Interventionen gemeinsam, also beide Videos und das Bestellformular. Die abhängige Variable war, ob die Proband:innen von einer Stufe in eine benachbarte höhere Stufe aufstiegen, was durch ein Follow-up Interview einige Zeit später erfasst wurde. Dabei wurde vorhergesagt, dass die Steigerung der Bedrohung sich eher in Stufe 3 und die Planungshilfe sich in Stufe 5 als wirksam erweist (*matched intervention*), die Interventionen in der anderen Stufe jeweils eher unwirksam sind (*mismatched intervention*). Für die Versuchspersonen beider Gruppen zeigte die Intervention der kombinierten Maßnahmen die stärksten Effekte: 54 % der Gruppe der Unentschlossenen und 36 % bei der Gruppe der Entschlossenen stiegen im PAPM mindestens eine Stufe auf. Bei der Gruppe der Unentschlossenen zeigte darüber hinaus die Intervention der Bedrohungssteigerung (42 % stiegen auf) einen signifikant stärkeren Effekt als die Intervention der Planungshilfe (36 % stiegen auf), während dies für die Gruppe der Entschlossenen ebenso hypothesenkonform ausfiel (Bedrohungssteigerung wirkte bei 10 % und Planungshilfe wirkte bei 32 %). In der Kontrollbedingung wurden insgesamt die geringsten Effekte erzielt, da in der Gruppe der Unentschlossenen 19 % aufstiegen und in der Gruppe der Entschlossenen 8 %. Auch wenn die Ergebnisse insgesamt hypothesenkonform ausfielen, lässt sich festhalten, dass in diesem Setting zumindest die Intervention für höhere Stufen auf den niedrigeren Stufen einen gewissen Effekt erzielte.

6.7.3 Das PAPM heute

Um die Validität des PAPM besser beurteilen zu können, fehlt es weiter an empirischen Studien und die existierenden Studien sind vorwiegend querschnittlich. Es ist weitaus weniger erforscht als das TTM und findet auch in der Praxis vergleichsweise weniger Niederschlag.

6.8 Rückfallmodell nach Marlatt und Gordon (Relapse Prevention Model, RPM)

Generell stammen Rückfallmodelle maßgeblich aus der Abhängigkeitsforschung. Zentral sind hierbei alle Prozesse und Faktoren, die daran beteiligt sind, dass ein Individuum ein gesundheitsförderndes Verhalten nicht mehr aufrecht hält und/oder zu einem ungesunden Verhalten zurückkehrt. Das RPM lässt sich weder den kontinuierlichen Prädiktionsmodellen noch den Stufenmodellen gänzlich zuordnen und betont in erster Linie volitionale Aspekte im Veränderungsprozess. Nach Schwarzer (2004) bestehen drei theoretische Ansätze, die einen Erklärungsmechanismus bieten und auf die im Folgenden näher eingegangen wird. Zwei Modelle, das moralische Modell und das Krankheitsmodell des Rückfalls, beinhalten gegensätzliche Erklärungen dafür, weshalb ein Mensch rückfällig wird. Das *moralische Modell* geht von einer Willens- und Charakterschwäche aus. Demnach werden Personen nur dann rückfällig, wenn sie charakterlich zu schwach sind, Versuchungen zu widerstehen. Gültigkeit besaß dieses Modell zwischen Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Wende wurde maßgeblich durch Jellinek (1960) und seinem *Krankheitsmodell des Rückfalls* eingeläutet, das davon ausgeht, dass süchtiges Verhalten genetisch veranlagt ist. Dabei wurde zunächst den Suchtkranken eine große Erleichterung verschafft, da sich nun die Gene und nicht die Persönlichkeit als verantwortlich für die Krankheit zeigen. Jedoch wird im Falle einer vollständigen Erklärung durch die Gene dem Menschen selbst



Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

sämtliche Verantwortung und auch Kontrollierbarkeit abgesprochen. Daher beschäftigen sich jüngere Modelle mit einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren, wobei hier Umweltbedingungen und Lernprozesse stärker einbezogen werden. Eine differenzierte Sichtweise stammt von Marlatt und Gordon (1985), die in den 80er Jahren das *Modell des Rückfallprozesses* (RPM) entwickelten, was für jegliches Suchtverhalten anwendbar ist.

6.8.1 Modellkomponenten des RPM

Im RPM (Marlatt & Gordon, 1985) finden sich kognitive und verhaltenstheoretische Komponenten aus den zuvor geschilderten Theorien zum Gesundheitsverhalten sowie Konzepte aus der Sozialpsychologie wieder. Kernelement ist, dass es sich bei Abhängigkeitsverhalten um etwas Erlerntes handelt, was nun wieder umgelernt werden muss. Erlernt wurde das Verhalten über operantes Konditionieren, also durch die positive oder negative Verstärkung, die durch das Suchtmittel erfahren wurde. So wirkt beispielsweise der Verzehr von hochkalorischem Essen zunächst angenehm (positive Verstärkung) und in Stresssituationen spannungsreduzierend (negative Verstärkung) und kann auf Dauer in Essattacken münden (siehe Kurs 1, Kapitel 8 „Ernährung und Essverhalten"). Strebt nun eine Person nach einer Veränderung bezüglich ihrer Abhängigkeit, werden zunächst potenzielle Auslöser eliminiert, indem analysiert wird, in welchen Funktionen das Suchtmittel als Verstärkung dient. Bleiben Personen erfolgreich abstinent (bzw. reduzieren ein Verhalten bezüglich gewisser Regeln), erleben sie ein gewisses Maß an Kontrolle beziehungsweise eine Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung, weshalb das Modell auch Selbstkontrollmodell genannt wird. Je länger Personen die Verhaltensänderung einhalten, desto mehr verstärkt sich dieses Gefühl.

Die Gefahr für einen Rückfall besteht besonders in sogenannten *Hochrisikosituationen*. Hierzu hat Marlatt (1996) vier Klassen identifiziert:

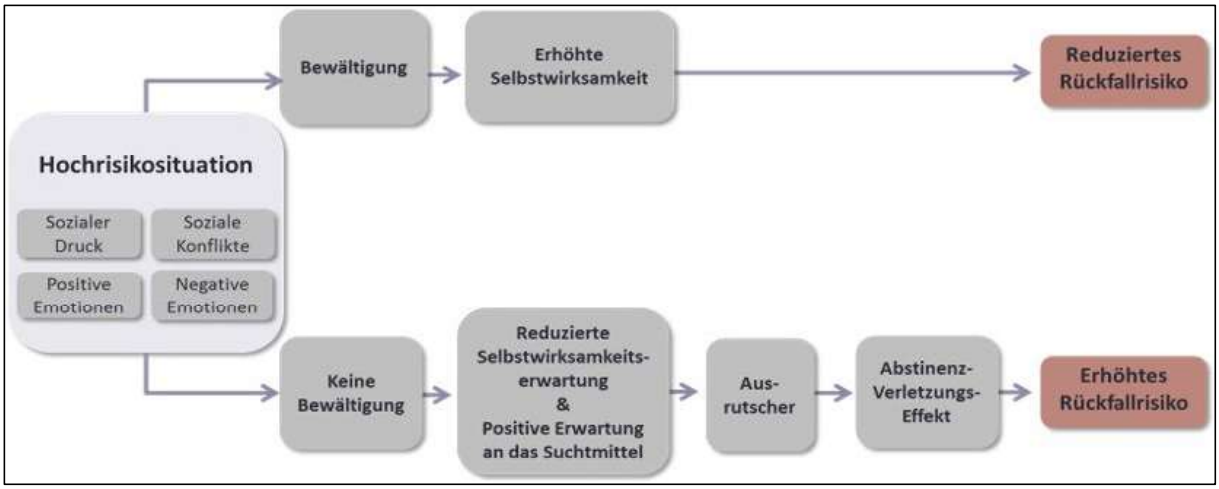
1. Negative emotionale Zustände (z. B. Angst, Ärger, Trauer),
2. soziale Konflikte (z. B. Familie, Arbeitsumfeld),
3. sozialer Druck (wenn die Mehrheit der Umgebung das Suchtverhalten ausübt),
4. positive emotionale Zustände (Austesten der Willensstärke).

Hierbei ist der erste Punkt, nämlich negative emotionale Zustände, für die meisten Rückfälle verantwortlich. Das Modell von Marlatt und Gordon (1985)zeigt in Hochrisikosituationen zwei Pfade auf, wie das weitere Verhalten aussehen kann. Wird die Situation erfolgreich bewältigt, steigert dies die Selbstwirksamkeitserwartung, was die Wahrscheinlichkeit, die nächste Situation erfolgreich zu meistern, ebenso steigert. Bei einem Rückfall reduziert sich die Selbstwirksamkeitserwartung und das Risiko eines kompletten Rückfalls steigt. Jedoch sind in diesem Pfad noch weitere Faktoren entscheidend. Ein Effekt, der in die Rückfallspirale führen kann, wird von Marlatt und Gordon (1985)*Abstinenz-Verletzungs-Effekt* genannt. Durch den Ausrutscher bestehen ein schlechtes Gewissen, Scham und auch Angst vor einem Rückfall. Damit stellen die negativen Gefühle durch Ausrutscher selbst eine zusätzliche Hochrisikosituation dar, in der ein Rückfall wahrscheinlicher wird. Ein weiteres wichtiges Element ist auch die *Attribution*, die der Rückfällige tätigt („Ich bin rückfällig geworden, weil ich ein schwacher Mensch bin" vs. „Die Situation war außergewöhnlich, da wäre jeder schwach geworden", siehe Kasten 6.1). Das Rückfallmodell ist in Abbildung 6.10 dargestellt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 6.10

Darstellung des Rückfallmodells nach Marlatt und Gordon (1985)



6.8.2 Befunde zum RPM

Einige Komponenten des Rückfallmodells nach Marlatt und Gordon (1985)liefern wichtige Ansatzpunkte für Interventionsmaßnahmen. Insbesondere die Identifikation von Hochrisikosituationen und der Umgang mit Rückfällen (z. B. Attributionen) stellen sich als bedeutsame Elemente bei der Bekämpfung von Abhängigkeit heraus. In einer Meta-Analyse von Irvin et al. (1999) mit insgesamt 26 Studien, die die Effektivität von Interventionsmaßnahmen, die auf dem RPM basieren, gegenüber anderen Modellen oder einer Kontrollbedingung prüften, zeigte sich, dass vor allem bei der Bekämpfung von Alkoholabhängigkeit und multiplem Substanzmissbrauch das RPM überlegen war. In einer Überarbeitung von Witkiewitz und Marlatt (2004) wurde die Abfolge der Komponenten aufgegeben, obwohl die Komponenten des Modells an sich unberührt blieben. Die revidierte Version bezieht situative Faktoren mit ein und geht zudem von einer wechselseitigen Beziehung der verschiedenen Faktoren im Modell aus.

6.8.3 Das RPM heute

Eine empirische Überprüfung der revidierten Fassung steht jedoch bis heute aus und könnte sich aufgrund der Komplexität des Modells als schwierig gestalten (vgl.Knoll et al., 2013). Bedeutsam ist das Modell heutzutage vor allem im Bereich der Sucht und Abhängigkeit und gestaltet sich hier insbesondere für die Rückfallprävention als wertvoll (Brinkmann, 2021).

6.9 Das sozial-kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns (Health Action Process Approach, HAPA)

Die Entwicklung des HAPA-Modells geht auf Schwarzer (1992) zurück. Ähnlich wie bei den Überlegungen zur Intentions-Verhaltens-Lücke (Intention-Behaviour Gap, IBG) werden in diesem Modell bestehende Konstrukte aus anderen Theorien zusammengeführt und Lösungen für empirisch nachweisbare Lücken vorgeschlagen (siehe Abschnitt 6.5). Durch die Berücksichtigung bestehender Theorien und Modelle handelt es sich bei dem HAPA um ein Hybrid-Modell, da es sowohl Komponenten aus kontinuierlichen Prädiktionsmodellen als auch Stufenmodellen berücksichtigt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

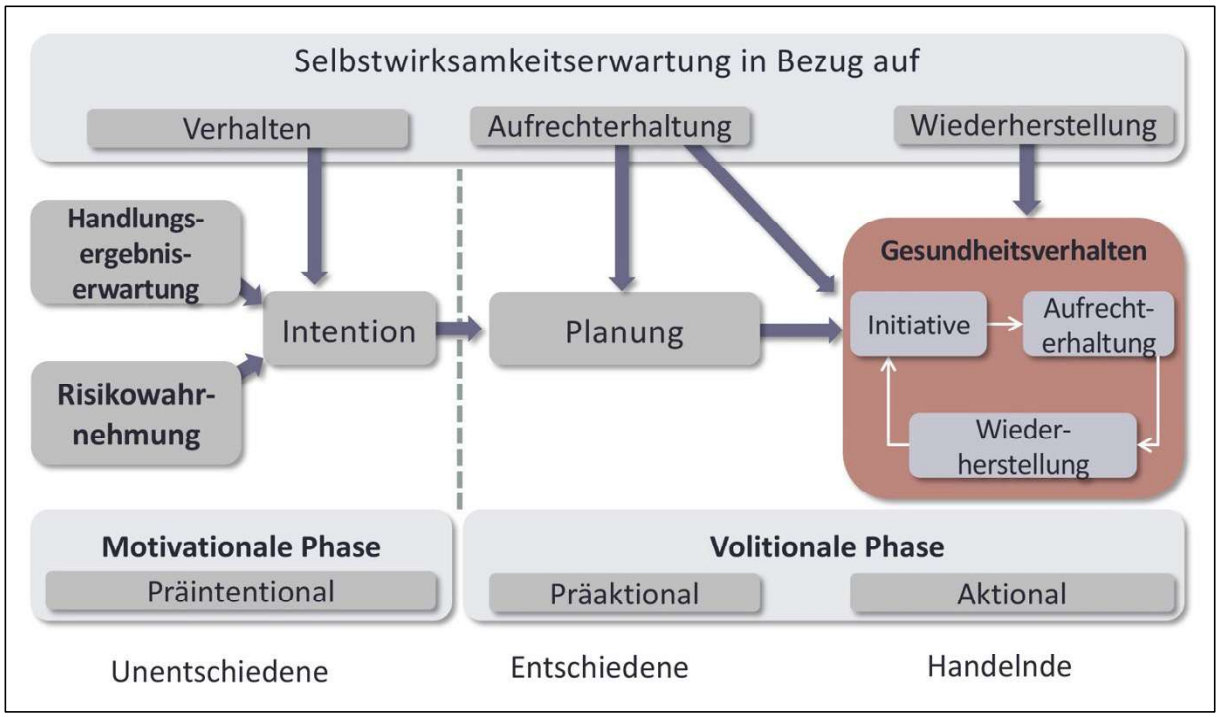
6.9.1 Modellkomponenten des HAPA

Wie auch in der Social Cognitive Theory (SCT) nach Bandura (1986) liegt im HAPA ein besonderer Fokus auf der Selbstwirksamkeitserwartung. Ist diese nicht zumindest zu einem gewissen Grad vorhanden, kann laut Modell keine Verhaltensänderung erfolgen. Weiter wird im HAPA zwischen den Phasen der Motivation und der Volition unterschieden (siehe Kasten 6.2). Eine vollständige Abbildung des HAPAs findet sich in Abbildung 6.11 (siehe auch Video 6.2).

In der *motivationalen Phase* (auch präintentionale Phase genannt) wirken insgesamt drei Komponenten auf die Bildung einer Intention: die Risikowahrnehmung (subjektive Einschätzung der Vulnerabilität und Schweregrad, Health Belief Model [HBM]), die Handlungsergebniserwartung (Einschätzung der Effizienz der Verhaltensänderung, TTM) und die Selbstwirksamkeitserwartung (Einschätzung der eigenen Fähigkeiten das Verhalten trotz widriger Umstände umzusetzen, SCT). Ist eine ausreichend starke Intention gebildet, wird in die volitionale Phase übergegangen. Wie auch die Forschung zur IBG bemängelt, sieht Schwarzer (2004) eine Vorhersage des Verhaltens aufgrund der reinen Intention als problematisch an, da Menschen aus verschiedenen Gründen zum Beispiel keine realistische Planung erstellen können oder weitere Probleme in der Durchführung und Aufrechterhaltung des gewünschten Verhaltens bekommen. So macht laut Schwarzer an der Wahrscheinlichkeit, ein Verhalten zu zeigen, die Intention lediglich ca. 20-30 % aus.

Abbildung 6.11

Darstellung des sozial-kognitiven Prozessmodells gesundheitlichen Handelns



In der *volitionalen Phase* werden verschiedene Subphasen unterschieden, die den Stufen des TTM ähneln. So unterscheidet das Modell – wie auch die Stufenmodelle – zwischen verschiedenen Personen: Die Unentschiedenen haben sich noch nicht zu einer Verhaltensänderung entschlossen, die Entschiedenen möchten in naher Zukunft eine Verhaltensänderung durchführen und die Handelnden befinden sich in der Phase der Verhaltensänderung. Die volitionale Phase beginnt mit der präaktionalen Phase in der zunächst das Verhalten (detailliert) geplant wird. Damit wird der Prozess der Planung in diesem Modell explizit als eigener Schritt aufgefasst, der sich von den

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

anderen abgrenzt. Die Selbstwirksamkeitserwartung umfasst an dieser Stelle die Erwartungen darüber, ob eine Person zum Beispiel in der Lage ist, eine günstige Situation für die Initialisierung des Verhaltens zu erkennen („Die nächsten zwei Wochen habe ich keine Einladungen, daher kann ich mit der Ernährungsumstellung beginnen"). Danach folgt die aktionale Phase. In dieser Phase ist ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erforderlich, da eine permanente Handlungsausführungskontrolle getätigt werden muss. Ebenso beansprucht der Prozess der Emotionsregulation mentale Ressourcen, da vermehrt negative Emotionen auftreten können, die nicht mehr durch das zu verändernde Verhalten (z. B. Rauchen, Schokolade essen, Fernsehen statt physischer Aktivität) kurzfristig reguliert werden. Das Ausmaß der Selbstwirksamkeitserwartung beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, ob das Verhalten aufrechterhalten wird. Zweifel an der Kompetenz, zum Beispiel Versuchungen widerstehen zu können, führen dazu, dass Personen schneller aufgeben. In der postaktionalen Phase (nicht in Abbildung 6.11 aufgeführt) wird das Verhalten bewertet und eine Ursachenzuschreibung (siehe Kasten 6.1) für mögliche Erfolge oder auch Misserfolge vorgenommen. Die Art der Attribution hängt mit der Selbstwirksamkeitserwartung direkt zusammen. Wird beispielsweise ein Misserfolg als internal und stabil attribuiert („Ich schaffe es nie, auf die Zigaretten abends zu verzichten, weil ich viel zu schwach bin") sinkt die Selbstwirksamkeitserwartung und die Wahrscheinlichkeit einen neuen Versuch zu initialisieren verringert sich. Möglicherweise findet aber auch eine bessere Einschätzung für zukünftige Versuche statt („Die Zigarette abends ist die schwierigste, hier brauche ich andere Strategien"). Dies könnte sich durch eine neue Zielsetzung ausdrücken („Ich möchte mit dem Rauchen aufhören, gönne mir zunächst jeden Abend genau eine Zigarette") oder auch durch eine bessere Planung („Ich verabrede mich die ersten zwei Wochen abends, so dass ich nicht zu Hause bin und in Versuchung gerate"). Da das HAPA auch Stufen berücksichtigt bietet es ebenso Anlass für maßgeschneiderte Interventionen. So kann mit Blick darauf, in welcher Phase sich die Personen befinden, geschaut werden, ob die Risikokommunikation gesteigert werden sollte (präintentionale Phase), Unterstützung bei der Planung gegeben werden kann (präaktionale Phase), oder auch Strategien zur Rückfallprävention aufgebaut werden (postaktionale Phase).

Schwarzer (2004) versteht sein Modell eher als Forschungsheuristik, da die Komponenten Elemente aus anderen Modellen zum Gesundheitsverhalten sind. Daher wurden die verschiedenen Komponenten des Modells auch bereits in vielen Studien untersucht. Ein Kritikpunkt hier ist, dass das Zusammenspiel der unterschiedlichen Komponenten damit nicht zwangsläufig überprüft wird.

Video 6.2. Health Action Process Approach (Ralf Schwarzer). Verfügbar unter https://youtu.be/OSwYAlz3deU

6.9.2 Befunde zum HAPA

Es handelt sich bei dem HAPA um ein Hybrid-Modell, das kontinuierliche Faktoren und gleichzeitig auch Stufen berücksichtigt. Die verschiedenen Komponenten des HAPA wurden in einer Studie von Payaprom et al. (2011) untersucht, die die Rate der Grippeschutzimpfungen in Thailand steigern sollte. Die Autor:innen wendeten keine maßgeschneiderte Intervention an, sondern schauten, ob eine auf dem HAPA fußende Intervention zu Veränderungen bezüglich der Intention und des tatsächlichen Impfverhaltens führt. Die Hälfte der Teilnehmenden erhielt Broschüren unter anderem mit Informationen zu Risikowahrnehmung, Ergebniserwartung, Selbstwirksamkeit, Intention und auch Handlungsplanung (z. B. bezüglich Ort, Zeitpunkt und Abläufen von Grippeschutzimpfungen; Experimentalgruppe, $n = 99$). Die Kontrollgruppe ($n = 102$) erhielt lediglich die staatlichen Standardinformationen zu Grippe und Grippeschutzimpfungen. Für die Experimentalgruppe sagten Selbstwirksamkeitserwartung, Handlungsergebniserwartung

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

und Planung die Veränderung der Intention vorher (Varianzaufklärung 46 %). Risikowahrnehmung stellte sich als schwacher Prädiktor für die Impfabsicht heraus. Trotz signifikanter Gruppenunterschiede bezüglich der Impfabsicht unterschieden sich die Impfraten nicht, was unter anderem mit der sehr hohen Anzahl an Impfungen in beiden Gruppen erklärt wurde. Die Impfabsicht und Selbstwirksamkeit sagten jedoch unabhängig von den fehlenden Gruppenunterschieden jeweils die Impfrate vorher.

In einer längsschnittlichen Studie prüften Luszczynska und Schwarzer (2003) mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells die Gültigkeit des HAPA an jungen Frauen, die selbst regelmäßig ihre Brust untersuchen sollten. Es wurden die verschiedenen Phasen des HAPA berücksichtigt und insbesondere der Einfluss der phasenspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung getestet. Während die Risikowahrnehmung kaum Effekte zeigte, war die präaktionale Selbstwirksamkeitserwartung der beste Prädiktor für die Intention. Planung wiederum stellte sich als bester Prädiktor für die Verhaltensänderung heraus und hatte damit einen stärkeren Einfluss als die aufrechterhaltungs- und wiederherstellungsbezogene Selbstwirksamkeitserwartung. Insgesamt konnte ein guter Modellfit erzielt werden (GFI = 0.906, RMSEA = 0.049).

In einer weiteren Studie von Luszczynska et al. (2007) verwendeten die Autor:innen eine Intervention zur Erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartung sowie eine Intervention zur Erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartung plus eine Unterstützung der Handlungsplanung, um eine Umstellung auf gesünderes Essverhalten zu bewältigen. Im Gegensatz zur Kontrollgruppe zeigten beide Interventionsgruppen nach einem halben Jahr ein gesünderes Essverhalten, jedoch konnte kein Unterschied zwischen den Interventionsgruppen festgestellt werden, was die Bedeutsamkeit der Selbstwirksamkeitserwartung wiederum unterstreicht.

6.9.3 Das HAPA heute

Viele der Modellkomponenten des HAPA zeigten sich in der Forschung als theoretische und praktische Prädiktoren für Gesundheitsverhalten. Weniger erforscht sind hingegen die auch im Modell erwähnten Hindernisse sowie Interaktionen zwischen individuellen Stärken, sozialen und strukturellen Ressourcen (Brinkmann, 2021).

6.10 Integrative Betrachtung

Die in den vorherigen Abschnitten geschilderten Theorien und Modelle beinhalten Variablen und Konstrukte, die der Vorhersage von Gesundheitsverhalten dienen. Festgehalten werden kann, dass sich über die verschiedenen Ansätze hinweg einige zentrale sozial-kognitive Determinanten wiederholen, die zwar teilweise anders benannt werden, jedoch insgesamt in einem Großteil der Theorien und Modelle eine bedeutende Rolle einnehmen (die IBG wurde bei dieser Aufzählung nicht berücksichtigt, da hier verschiedene Autor:innen unterschiedliche Ansätze für die Erklärung der Lücke heranziehen). Dazu gehören:

- Selbstwirksamkeitserwartung (SCT, Protection Motivation Theory [PMT], TTM, HAPA, RPM; in der Theory of Planned Behavior [TPB]: Kontrollüberzeugung)
- Ergebniserwartung/Annahmen über Konsequenzen (HBM, PMT, TPB, SCT, PAPM, TTM, HAPA)
- Risikowahrnehmung/Bedrohungseinschätzung (HBM, PMT, PAPM, TTM, HAPA)
- Intention/Ziele (PMT, TPB, SCT, HAPA)

Für alle diese Determinanten konnte empirisch ein gewisser Einfluss auf das Gesundheitsverhalten nachgewiesen werden. Ebenso lässt sich festhalten, dass viele Theorien im großen Maße Ähnlichkeiten und Überschneidungen aufweisen, aber jede Theorie hat auch für

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

sich zu wertvollen Erkenntnissen geführt. Diese mögen für verschiedene Bereiche eine unterschiedliche Relevanz besitzen. Wichtige Implikationen für die Praxis und die Arbeit mit Menschen bieten die Rückfallmodelle, speziell für die Analyse von Hochrisikosituationen. Auch einzelne Komponenten aus Modellen besitzen hier Relevanz, wie zum Beispiel die Selbstwirksamkeitserwartung oder Aspekte der Planung. Für die Konzeption von Gesundheitskampagnen sind vor allem Aspekte wichtig, die die Motivation steigern, wie die Risikowahrnehmung oder Handlungsergebniserwartung. Nichtsdestotrotz ist die Effektivität dieser Modelle für die Praxis als noch immer nicht zufriedenstellend zu beurteilen (Luszczynska, 2016). So sollen insbesondere emotionale und soziale Faktoren in Zukunft stärker berücksichtigt werden. Die Forschung ist zudem maßgeblich an Prädiktoren interessiert, die (Gesundheits-) Verhalten vorhersagen. Daher benötigt die Wissenschaft falsifizierbare Modelle, um Varianzaufklärung oder einen Modellfit zu berechnen. Offen bleiben für die Forschung ebenso klinische Effekte für Interventionen auf Basis der verschiedenen Theorien und Modelle in Langzeitstudien und in experimentellen Studien zu prüfen. Darüber hinaus sollte die Gültigkeit über verschiedene Populationen hinweg und in verschiedenen Umwelten getestet werden.

Literaturverzeichnis

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Hrsg.), *Action control: From cognition to behavior* (S. 11–39). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

Ajzen, I. (2015). The Theory of Planned Behaviour is alive and well, and not ready to retire: A commentary on Sniehotta, Presseau, and Araújo-Soares. *Health Psychology Review*, *9*(2), 131–137. https://doi.org/10.1080/17437199.2014.883474

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. *Psychological Bulletin*, *84*(5), 888–918. https://doi.org/10.1037/0033-2909.84.5.888

Armitage, C. J. & Conner, M. (2000). Social cognition models and health behaviour: A structured review. *Psychology & Health*, *15*(2), 173–189. https://doi.org/10.1080/08870440008400299

Bagozzi, R. P. & Pieters, R. (1998). Goal-directed emotions. *Cognition & Emotion*, *12*(1), 1–26. https://doi.org/10.1080/026999398379754

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, *84*(2), 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A Social Cognitive Theory*. Prentice Hall.

Becker, M. H. (1974). *The Health Belief Model and personal health behavior*. Slack.

Brinkmann, R. (2021). *Angewandte Gesundheitspsychologie* (2. Aufl.). Pearson.

Carpenter, C. J. (2010). A meta-analysis of the effectiveness of health belief model variables in predicting behavior. *Health Communication*, *25*(8), 661–669. https://doi.org/10.1080/10410236.2010.521906

Carter, M. C., Burley, V. J., Nykjaer, C. & Cade, J. E. (2013). Adherence to a smartphone application for weight loss compared to website and paper diary: Pilot randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, *15*(4), e32. https://doi.org/10.2196/jmir.2283

Conner, M. (2015). Extending not retiring the theory of planned behaviour: A commentary on Sniehotta, Presseau and Araújo-Soares. *Health Psychology Review*, *9*(2), 141–145. https://doi.org/10.1080/17437199.2014.899060

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440